

No.

00000056

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

CONSIDERANDO:

- Que, es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos internacionales en particular la salud, conforme lo dispone el artículo 3, numeral 1 de la Norma Suprema;
- Que, *"La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional."*, acorde a lo prescrito en el artículo 32 de la citada Constitución de la República del Ecuador;
- Que, es facultad del Ministerio de Salud Pública, en su calidad de Autoridad Sanitaria Nacional, ejercer la competencia de emitir políticas públicas en salud, de acuerdo con lo previsto en los artículos 261 numeral 6 y 361 de la Norma Suprema de la República, y en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud;
- Que, es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: *"6. Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención y atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera"*; según lo dispone el numeral 6 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud;
- Que, a fin de llevar a cabo acciones para la mejora continua de la calidad y sostenibilidad de los programas de cuidado materno neonatal, además de garantizar la calidad de las prestaciones que se brindan en el Sistema Nacional de Salud, es necesario contar con un instrumento que permita vigilar los eventos antes mencionados;
- Que, el Ministerio de Salud Pública, previo conocimiento y autorización, ha procedido a adaptar el formulario de la Historia Clínica Perinatal del Centro Latinoamericano de Perinatología/Salud de la Mujer y Reproductiva CLAP/SMR de Uruguay, para uso del Sistema Nacional de Salud; y,

En ejercicio de las atribuciones contempladas en el artículo 154, numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador

ACUERDA:

- Art. 1.- Aprobar el "Formulario 051" para la "Historia Clínica Materna Perinatal", y su instructivo, anexos al presente Acuerdo y parte integrante del mismo, que será de uso obligatorio en el Sistema Nacional de Salud.
- Art. 2.- De la ejecución y difusión del presente Acuerdo Ministerial, encárguese a la Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud a través de la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud, Dirección



Ministerio
de Salud Pública

00000056

Nacional de Hospitales; a la Subsecretaría Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud, a través de la Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud y, a la Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud, a través de la Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud.

Art. 3.- El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a **15 JUN. 2016**


Dra. Margarita Guevara Alvarado
MINISTRA DE SALUD PÚBLICA



	Nombre	Área	Cargo	Sumilla
Aprobado	Dra. Verónica Espinosa	Viceministerio de Gobernanza y Vigilancia de la Salud	Viceministra	
	Dra. Jakeline Calle	Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud	Subsecretaria	
	Dr. Paul Proaño	Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud	Subsecretario	
	Ing. Juan Carlos Almeida Bonilla	Subsecretaría Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud	Subsecretario (E)	
	Mgs. Paulina Ríos	Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud	Gerente Institucional de Implementación de Disminución Mortalidad Materna	
	Mgs. Carmen Guerrero	Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud	Directora	
	Dra. Jenniffer Florencia	Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud	Directora	
Solicitado y aprobado	Dra. Martha Gordón	Dirección Nacional de Normatización	Directora	
Revisado	Dr. Juan Alvear		Director	
Elaboración Acuerdo Ministerial	Abg. Alexandra Arteaga	Dirección Nacional de Consultoría Legal	Analista	
Adaptación	Dra. Linda Arturo	Hospital Gineco Obstétrico Maternidad Isidro Ayora	Pediatra	
	Dra. Esther Castillo	Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud	Analista	
	Obs. Carolina Puetate	Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud	Analista	
	Ing. Jasmin Carranza		Analista	
Revisión del Instructivo	Dra. Ximena Raza	Dirección Nacional de Normatización	Técnica	

Historia Clínica Materna Perinatal "Formulario 051"

Instructivo 

2016

Ficha catalográfica:

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Historia Clínica Materna Perinatal "Formulario 051", Instructivo. Quito: Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud, Subsecretaría Nacional de Garantía de la Calidad, 2016, pág. 95.

Edición general: Dirección Nacional de Normatización

Ministerio de Salud Pública

Subsecretaría Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud. Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud.

Edificio OBRUM, piso 10, Teléfono: 593-2-381-4400

Página Web: www.msp.gob.ec

Documento Adaptado: Historia Clínica Materna Perinatal y Formularios Complementarios

Publicación Científica CLAP/SMR 1572, 2010.

Cómo citar este documento:

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Historia Clínica Materna Perinatal "Formulario 051". Instructivo. Dirección Nacional de Normatización y Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud, Abril, 2016, Quito, Ecuador.

Diseño e impresión:

Impreso en Quito - Ecuador

Autoridades

Dra. Margarita Guevara, Ministra de Salud Pública
 Dra. Verónica Espinosa, Viceministra de Gobernanza y Vigilancia de la Salud
 Dr. Laureano Restrepo, Viceministro de Atención Integral en Salud
 Dra. Jakeline Calle, Subsecretaria Nacional de Gobernanza de la Salud
 Ing. J. Carlos Almeida, Subsecretario Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud (E)
 Dr. Paúl Proaño, Subsecretario Nacional de Provisión de Servicios de Salud
 Mgs. Consuelo Santamaría, Subsecretaria Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad
 Dra. Jenniffer Florencia, Directora Nacional de Calidad de los Servicios de Salud
 Dra. Martha Gordón, Directora Nacional de Normatización.

Edición general

Dirección Nacional de Normatización

Equipo de Redacción Montevideo- Uruguay

Fescina RH, Centro Latinoamericano de Perinatología / Salud de la Mujer y Reproductiva CLAP/SMR
 De Mucio B, Centro Latinoamericano de Perinatología / Salud de la Mujer y Reproductiva CLAP/SMR
 Martínez G, Centro Latinoamericano de Perinatología / Salud de la Mujer y Reproductiva CLAP/SMR
 Díaz Rossello JL, Centro Latinoamericano de Perinatología / Salud de la Mujer y Reproductiva CLAP/SMR
 Mainero L, Centro Latinoamericano de Perinatología / Salud de la Mujer y Reproductiva CLAP/SMR
 Rubino M, Centro Latinoamericano de Perinatología / Salud de la Mujer y Reproductiva CLAP/SMR

Equipo de revisión- adaptación Ecuador

Dra. Linda Arturo, pediatra, Hospital Gineco Obstétrico Maternidad Isidro Ayora.
 Dra. Jenny Benalcazar, ginecóloga, Hospital Gineco Obstétrico Maternidad Isidro Ayora.
 Obst. Carolina Puetate, analista, Mejoramiento Continuo de la Calidad, DNCSS/MSP

Equipo de validación interna

Ing. Lorena Carranza, Coordinadora de Mejoramiento Continuo de la Calidad, MSP.
 Dra. Esther Castillo, analista, Gerencia Institucional de Reducción de Muerte Materna, MSP.
 Lic. Margarita Cañar, analista, Gerencia Institucional de Reducción de Muerte Materna, MSP.
 Md. David Armas, analista, Dirección Nacional de Normatización, MSP.
 Lic. Sofia Pozo, analista, Subsecretaría Nacional de Provisión de los Servicios de Salud, MSP.
 Dr. Roberto Ponce, médico, Quito.
 Dra. Melisa Cadena, médico, Quito.
 Dra. Zoila Salazar, analista, Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud,

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "C.P.", "2", "H.C.", and other illegible marks.

MSP.

Obsta. Jhon Arias, analista, Dirección Nacional de Salud Intercultural, MSP.

Lic. Ruvi Paola Guzmán Naranjo, analista, Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud, MSP.

Dra. Betzabé Tello, médica, Quito.

Equipo de validación externa

Dr. Francisco Delgado, ginecólogo, Hospital Pablo Arturo Suárez.

Dr. Carlos A. Molina, ginecólogo, Hospital General de Macas.

Dr. Benito Bayas, ginecólogo, Hospital Docente de Riobamba.

Dr. David López, ginecólogo, Hospital Alfredo Noboa Montenegro.

Dr. Iván Cevallos, ginecólogo, Hospital Enrique Garcés.

Dr. Rodrigo Rosillo, ginecólogo, Hospital Ángela Loayza de Ollague.

Dra. Sasky Falcones, ginecóloga, Hospital Especializado Marina de Jesús

Dra. Verónica Hidalgo, ginecóloga, Hospital Tena.

Dr. José Alcivar, ginecólogo, Hospital General de Chone

Dra. Silvia Duchicela, neonatólogo, Hospital General de Macas.

Dr. Freddy Alcivar, neonatólogo, Hospital Alfredo Noboa Montenegro

Dr. Enrique Mulet, neonatólogo.

Dr. Pedro Galiano, neonatólogo, Hospital Teófilo Dávila.

Dr. Fabián Valencia, neonatólogo, Hospital Provincial de Ambato.

Dra. Cecilia Cevallos, neonatóloga, Hospital Ángela Loaiza

Dr. Jorge Cruz, pediatra, Hospital Liborio Panchana

Dr. Miguel Hinojosa, pediatra, Hospital Enrique Garcés

Dra. Ana Belén Tamayo, pediatra, Hospital Luis G Dávila.

Dra. Iris Orozco, pediatra, Hospital Miguel H Alcivar.

Dra. Jenny Panchi, pediatra, Hospital San Vicente de Paúl.

Dr. J. Carlos Herrería, pediatra, Hospital Especializado Marina de Jesús.

Dr. Federico Tixi, médico tratante, Hospital Docente de Riobamba.

Dra. Dayana Imbaquingo, médico residente, Hospital San Vicente de Paúl.

Dr. Ángel Barre, médico residente, Hospital Delfina Torre de la Concha.

Dra. Mónica Paladines, Líder de Calidad, Coordinación Zonal 9.

Dra. R. Isabel Monge, Coordinadora, Gineco Obstetricia, Hospital Dr. G Dávila.

Lic. R. Elena Lara, Líder de Calidad, Coordinación Zonal 3.

Dr. Víctor Vélez Acosta, Líder de Calidad, Coordinación Zonal 4

Dr. Fabián Chango, Líder de Calidad, Coordinación Zonal 2.

Dra. Gabriela Carranza, Hospital Delfina Torres de Concha..

Dr. Jorge Merchán, Jefe de Ginecología, Hospital Liborio Panchana.

Lic. Mercy Aguayo, Zona 4

Dra. Elsa Díaz, Coordinadora de Calidad, Hospital Especializado Marina de Jesús.

Dra. Ximena Raza, magister en salud pública, Coordinadora de la DNN-MSP

Dra. Mirian Viteri, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas

Dr. Jaime Sandoval, Policía Nacional – Dirección de Salud

Dra. Marianela Robalino, Hospital Carlos Andrade Marín

Dr. Freddy Vallejo, Policía Nacional – Dirección de Salud

Lic. Anabel Ponce, analista, Gerencia Institucional de Reducción de Muerte Materna, MSP.

Contenido

1. Presentación

2. Introducción

3. Antecedentes

4. Objetivos

Objetivo general

Objetivos específicos

5. Alcance

6. Definiciones

7. Desarrollo

Sección: Antecedentes familiares, personales y obstétricos

Sección: Gestación actual

Sección: Parto / Aborto

Sección: Morbilidad

Sección: Postparto

Sección: Morbilidad Materna Grave (NEAR MISS)

Sección: Recién nacido

Sección: Egreso del recién nacido

Sección: Egreso materno

Sección: Anticoncepción

Sección: Detalles en Partograma

8. Abreviaturas

9. Referencias Bibliográficas

10. Anexos

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "P. d.", "D. 2020", "C. P.", and "R. P.", along with the number "4" and the word "nec".

1. Presentación

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador como ente rector del Sistema Nacional de Salud ha considerado pertinente la adaptación de la Historia Clínica Perinatal del Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP)/ Salud de la Mujer y Reproductiva (SMR), para desarrollar la Historia Clínica Materna Perinatal (HCMP) "Formulario 051"; lo que permite mantener actualizado su contenido con la mejor evidencia científica disponible, así como también incluir las prioridades nacionales, definidas por el MSP.

Uno de los objetivos del Desarrollo del Milenio, es mejorar las condiciones de vida de las madres y sus recién nacidos, es por eso que una de las estrategias más costo efectivas para alcanzar estos logros, es capacitar al equipo de salud en la atención continua de los cuidados de la madre y del recién nacido.

El presente documento plantea un plan estratégico a nivel nacional, para su adaptación e implementación, que responden a líneas estratégicas, orientadas a disminuir la mortalidad materna, perinatal y neonatal y a mejorar la salud de las mujeres y los/as recién nacidos/as.

En este sentido, el Ministerio de Salud Pública, como Autoridad Sanitaria Nacional, despliega todos sus esfuerzos de carácter administrativo, técnico, organizacional con la finalidad de viabilizar la institucionalización de la garantía de la calidad en cada uno de los establecimientos y niveles de atención del Sistema Nacional de Salud, para lo cual pone a disposición de todos/as los servidores, trabajadores y profesionales de la salud, el presente instructivo, diseñado con el fin de facilitar la atención, el monitoreo y la supervisión del cumplimiento de las normas, de tal manera que el sistema de salud cuente con información precisa y oportuna para la toma de decisiones.

Dra. Margarita Guevara

Ministra de Salud Pública

2. Introducción

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, plantean un gran desafío referente al monitoreo de los indicadores de las metas relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Los sistemas de información deben estar orientados a facilitar el cumplimiento de estos compromisos además de garantizar la calidad de las prestaciones que se brindan. Esta calidad de la atención se sustenta en la organización de los servicios y en un sistema de información adecuado para que el profesional que atiende al paciente, en el lugar y momento de la atención, disponga de una Historia Clínica apropiada y un flujo de la información que garantice los datos necesarios para el correcto manejo.

La riqueza de datos contenidos en la Historia Clínica Materna Perinatal (Formulario 051), permite construir el banco de datos más valioso con que cuenta el equipo de salud, ya sea para conocer las características de la población prestataria, evaluar los resultados de la atención brindada, identificar los problemas prioritarios, monitorizar indicadores claves y/o realizar investigaciones operacionales y epidemiológicas.

En este instructivo se describe en detalle la forma de llenado y la definición e interpretación de cada una de las variables que presenta la Historia Clínica Materna Perinatal (Formulario 051).

3. Antecedentes

A nivel de país, las bases de datos producidas por los establecimientos de salud son agregadas y analizadas para construir estándares e indicadores de mejora de la calidad de la atención, relacionados con las variables de la Historia Clínica Materna Perinatal (Formulario 051) a nivel de establecimientos de salud. El equipo de mejoramiento continuo de la calidad del Ministerio de Salud Pública, mediante la auto medición y autoevaluación, analiza la información, reconoce las brechas y desarrolla acciones para mejorar la calidad de atención en forma continua y con el reporte e informe correspondiente.

La Historia Clínica Materna Perinatal (Formulario No. 051) se convierte en un instrumento para la vigilancia epidemiológica de eventos maternos neonatales, para la evaluación de programas nacionales y regionales, así como para desarrollar acciones que lleven a la mejora continua de la calidad y den sostenibilidad a los programas de cuidado materno neonatal.

La Historia Clínica Materna Perinatal (Formulario No. 051) es para uso de los profesionales de la salud que atienden a madres embarazadas, parturientas, puérperas y recién nacidos, en los establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel de atención de la Red Pública Integral de salud y Complementaria. .

Su utilidad radica en que los datos clínicos maternos y neonatales desde la gestación, hasta el puerperio y nacimiento se presentan en una sola página. La mayor parte de datos clínicos sólo requieren registrar una marca en espacios previamente pre-definidos y aquellos datos que requieren mayor información, estudio, seguimiento y alerta son registrados en color amarillo.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "C.P.", "M.C.", and "A."]

4. Objetivos

Objetivo general

Orientar al profesional de la salud que realiza atención materna y neonatal, en el llenado de Historia Clínica Materna Perinatal (Formulario No. 051) con el fin de registrar datos completos de la atención de la madre y del recién nacido, siendo un instrumento de interés social, legal y de toma de decisiones, para la embarazada, su hijo/a, el equipo de salud y la institución responsable de la atención.

Objetivos específicos

1. Describir en detalle la forma de llenado y la definición e interpretación de cada una de las variables que presenta la Historia Clínica Materna Perinatal.
2. Facilitar al personal de salud el registro de datos con el fin de generar información útil para la toma de decisiones oportunas, correctas y acorde al Modelo de Atención Integral de Salud y de interés legal para la embarazada, su hijo/a, el equipo de salud y la institución responsable de la atención.
3. Proporcionar un instrumento para la capacitación del equipo de salud.

5. Alcance

Este instructivo es de uso y cumplimiento obligatorio en todos los establecimientos de salud de la Red Pública Integral de Salud y Complementaria.

6. Definiciones

Autoidentificación étnica: acto individual de reconocimiento explícito y contextualizado de la pertenencia a un grupo étnico, sobre la base de los marcadores étnicos compartidos por el grupo de referencia; y que siempre implican un ejercicio de contrastación con otro. Es evidente que los marcadores étnicos además estarán fuertemente influenciados por el contexto de discriminación y /o revitalización étnica.

Apego inmediato: es el inicio de la integración madre-hijo, piel con piel desde los primeros minutos de vida. Favorece el inicio exitoso de la lactancia materna y el vínculo emocional madre-hijo. Es un derecho universal y recomendado por la OMS.

Cédula de Identidad: Es el documento público que tiene por objeto identificar a las personas ecuatorianas y las extranjeras que se encuentren en el Ecuador de conformidad a la ley de la materia.

Consejería en lactancia materna: es la entrega sistematizada y oportuna a la madre embarazada y su familia de la siguiente información:

- Beneficios de la leche materna y los riesgos de la alimentación con leche artificial.
- Formas de amamantar.
- Los cambios en la leche materna después del parto y
- Discutir las dudas y preguntas.

Curva de dilatación: es la línea que muestra la evolución de la dilatación del cuello uterino para una embarazada determinada.

Curva de alerta: es la línea que se construye al inicio del trabajo de parto activo, según tiempos definidos por las condiciones maternas específicas y que al ser cruzada por la curva de dilatación obliga la reevaluación integral del binomio madre – hijo para la medición de nuevas decisiones que permitan un desarrollo adecuado del parto. La curva de alerta representa el percentil 90 (p90) de la dilatación de una población de referencia, es decir que el 90% de las madres han tenido su parto antes del tiempo estipulado por dicha curva o en contraposición, solo el 10% de las madres se demorarán más del tiempo estipulado por la línea de alerta para el nacimiento y por lo tanto en este grupo estarán las madres que tendrán una mayor probabilidad de presentar distocias.

Embarazo planificado: momento en el cual una pareja quieren ser padres o una mujer quiere ser madre. Para ello, la pareja tomará una serie de medidas que aseguren que la posibilidad de quedar embarazada se reduce al mínimo durante el periodo deseado.

Educación prenatal: corresponde a dar consejería a la madre embarazada y su familia acerca de los cambios que ocurren en la gestación y aquellos esperados durante el parto y el puerperio. Informar sobre técnicas de relajación y respiración, aumentar la percepción de autocontrol, entre otros.

Historia Clínica Materna Perinatal: es un instrumento diseñado para ayudar a la toma de decisiones relacionadas con el manejo clínico individual de la madre (durante el control prenatal, parto y puerperio) y del neonato (desde el nacimiento hasta el momento del alta).

Hospitalización en embarazo: se refiere a hospitalizaciones ocurridas por razones diferentes al parto. Si han existido hospitalizaciones durante el embarazo, se registrará el círculo amarillo que indica si, en ese caso también se deberá registrar el número total de días de hospitalización, (de la única internación o la suma de días de todas las internaciones).

Inmunoglobulina anti – Rh (D): la inmunoglobulina anti-Rh (D) es un anticuerpo pasivo que solo evita la inmunización, hecho que obliga a administrar una nueva dosis cada vez que se produce una nueva exposición. Es utilizada para la prevención de la Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido de madres Rh negativas y la profilaxis de la inmunización (Rho) en personas Rh negativas después de una transfusión incompatible de sangre total, concentrado de eritrocitos o plaquetas Rh positivo.

Mestiza: Resultado biológico de la combinación de grupos fenotípicos diferentes, proveniente de Europa, África y los pueblos indígenas originarios de América.

Muertos 1ra semana: se refiere a los recién nacidos que nacieron vivos pero que murieron dentro del período comprendido entre el nacimiento y el séptimo día (6 días, 23 horas, 59 minutos) y se marcará con una (X) el círculo correspondiente.

Muertos después 1ra semana: se refiere a los recién nacidos que nacieron vivos pero que murieron después de la primera semana de vida (7 días o más). No hay límite superior e incluye las muertes ocurridas hasta el mismo día de la consulta, lo que se marcará con una (X) el círculo correspondiente.

Muerto anteparto: se define como la muerte fetal que ocurre en la segunda mitad del embarazo, sin labor de parto presente, por causas ambientales, maternas o fetales.

Muerto parto: muerte del feto que ocurrió durante el trabajo de parto (período de dilatación o expulsión).

Muerto ignora momento: si no se puede precisar el momento en que se produjo la muerte del feto.

Nacimiento: culminación del embarazo, el periodo de salida del bebé del útero materno.

Partograma: es el formato para el registro objetivo y sistematizado del trabajo de parto.

Peso EG (peso para edad gestacional): se refiere al peso del recién nacido en relación a su edad gestacional, se usa un patrón de referencia de la distribución de peso en las diferentes edades gestacionales.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including "AN", "C.P.", "H.C.", and a circled "R".

Peso inicial: se refiere al peso en kilogramos de la madre en el primer control prenatal. Este dato es útil para evaluar el estado nutricional de la mujer antes del embarazo. La medida más utilizada es el Índice de Masa Corporal (IMC) que se calcula dividiendo el peso en kilogramos (Kg) sobre el cuadrado de la talla expresada en metros (m²). Por ejemplo, si la madre embarazada pesaba antes del embarazo 60 Kg y tiene una talla de 1.60 m, el cálculo será: $60 / 1.60^2 = 23.44$ IMC.

Lactancia materna exclusiva: se refiere a si el recién nacido solo ha recibido leche materna y ningún otro líquido o leche artificial.

Lactancia no exclusiva: se refiere a si el recién nacido recibió leche materna y además líquidos o leche artificial (sucedáneo).

Línea de base: es la línea a partir de la cual se inicia la construcción de las curvas de alerta.

Recién Nacido: niño/a que nace vivo/a, producto de una gestación de 22 semanas o más; desde que es separado/a del organismo de la madre hasta que cumple 28 días de vida extrauterina.

Trabajo de parto activo: presencia de contracciones uterinas efectivas que produzcan borramiento, dilatación del cuello uterino.

Último embarazo: indagar sobre el peso del recién nacido en el último embarazo. Marcar si pesó menos de 2500 gramos, fue mayor o igual a 4000 gramos, o n/a (no aplica) si no hubo nacimientos previos.

Vigilancia materna y fetal: cuidado continuo provisto durante el trabajo de parto para la identificación oportuna de la aparición de riesgos o complicaciones.

Viven: se refiere al número de hijos que están vivos al momento de la consulta.

7. Desarrollo

La Historia Clínica Materna Perinatal- HCMP "Formulario 051", es una herramienta útil para la vigilancia de eventos maternos y neonatales, en todos los niveles de atención, por lo cual es esencial que los datos registrados sean veraces, completos, válidos, confiables, estandarizados y legibles.

Las secciones de la HCMP cuentan con diferentes formas para la recolección de datos			
En algunas secciones hay espacios libres que admiten la escritura de letras y números, como se ve en el ejemplo.	Dirección Domicilio: Av. 5 de Junio y Gral. Miller		
Otros secciones son de forma rectangular y solo admite números.	Edad (años) <table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td></tr></table>	2	0
2	0		
Cuando los datos registrados son marcados en el círculo amarillo, se considerará los mismos como un signo de alerta	○ ○		
La forma correcta de marcar los círculos es con una x de la siguiente manera:	⊗		
Evitar otro tipo de llenado, por ejemplo:	◐ ◑ ○ /		

En el llenado de la Historia Clínica Materna Perinatal "Formulario 051", no se aceptan tachones, enmendaduras, utilización de corrector, ya que es un documento médico legal y se debe garantizar la calidad.

Secciones de la Historia Clínica Materna Perinatal "Formulario 051"

La Historia Clínica Materna Perinatal- HCMP "Formulario 051", consta de diferentes secciones, cada una de ellas se encuentran estructuradas de acuerdo a la relación entre variables.

Sección 1: Datos Generales

Objetivo: identificar a la madre embarazada desde un punto de vista civil

- Nombre, apellido, identificación de la embarazada.
- Nacionalidad que pueden orientar al origen étnico, además de las costumbres y hábitos culturales.
- Edad, orienta hacia las distintas posibilidades patológicas dependiente de este factor.
- Residencia, orienta a los problemas de accesibilidad a los servicios de salud, así como las condiciones propias de la región.
- Ocupación, orienta sobre las condiciones vinculadas con el trabajo.

DATOS GENERALES	
NOMBRES:	APELLIDOS:
Residencia habitual de la madre: (División Política Administrativa)	
Provincia: _____	
Cantón: _____	
Parroquia: _____	
Dirección Domicilio: _____	

1.1 Nombres – Apellidos

Llenar el espacio con los nombres y apellidos (paterno y materno) de la madre embarazada.

1.2 Residencia habitual de la madre

Provincia-Cantón-Parroquia- Dirección Domicilio

Se refiere a la residencia habitual de la madre embarazada.

Anotar el nombre de la provincia, cantón, parroquia, dirección, domicilio. Registrar la dirección completa (calle principal, número de casa y calle transversal).

Si no se puede identificar el domicilio con estos datos, anotar otra referencia que facilite su ubicación. (Ej. Junto a la iglesia).

1.3 Cédula de Identidad/ historia clínica

Anotar en el recuadro correspondiente el número de la historia clínica ó la Cédula de Identidad de la madre embarazada. En caso de no contar con el documento de identificación, anotar el código temporal según el Acuerdo Ministerial No. 00004934.

[Handwritten signatures and stamps]
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20

1.4 Teléfono (TELEF), anotar el número de teléfono del domicilio habitual de la madre embarazada. Si no lo tiene, se anotará un número de teléfono alternativo (familiar) o un número celular que permita la comunicación del establecimiento de salud con la familia.

1.5 Nacionalidad

De acuerdo al Art. 6 de la Constitución del Ecuador, todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional.

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad.¹

Seleccionar una de las dos opciones que se contemplan en el recuadro. Señalar con una (X); ecuatoriana o extranjera según corresponda.

Si selecciona extranjera, colocar en la opción **¿Cuál?** la nacionalidad a la que la madre embarazada pertenece.

1.6 Fecha de nacimiento

Anotar día, mes y año de nacimiento de la madre embarazada (dd/mm/aaaa).

Ejemplo:

26/09/1987

***Nota:** en caso de que la madre embarazada no recuerde la fecha exacta de su nacimiento, pregunte la edad y calcule el año aproximado de nacimiento. Ejemplo: paciente indica tener 20 años, reste al año correspondiente (2016) la edad (20), en este caso la fecha aproximada de nacimiento sería 01/01/1996.*

1.7 Edad (años)

Al momento de la primera consulta preguntar: **¿Cuántos años cumplidos tiene?**

Anotar la respuesta en el espacio disponible. Cuando la madre es menor a 15 años o mayor a 35 años, marcar el casillero amarillo.

1.8 Auto identificación étnica²

Seleccionar con una (X) una de las opciones de la variable de autoidentificación étnica (indígena, afro ecuatoriana/afrodescendiente, negra, mulata, montubia, mestiza, blanca y otra). Seleccionar otra a cualquier opción que no incluya las anteriores, por ejemplo etnias no reconocidas

La forma de obtener el dato podría ser: **¿Cómo se considera? ¿blanca? ¿indígena? etc.**

Indígena: persona con una identidad cultural definida que se auto identifica como tal, en relación a su pertenencia a un pueblo y/o nacionalidad originaria, anterior a la constitución del Estado Ecuatoriano.

Afro ecuatorianas: esta categoría se desprende del etnónimo afrodescendiente, denota a los descendientes de africanos que sobrevivieron a la trata esclavista en las

Américas, además comprende una doble adscripción o pertenencia del sujeto: tanto a las raíces africanas "afro como a la nación ecuatoriana".

Negra: personas descendientes de africanos en América. Obedece a rasgos de identificación socio cultural que tienen que ver con la pigmentación de la piel y la constitución somática del cuerpo.

Mulata: personas descendiente de africanos mezclado socio racialmente con poblaciones blancas o mestizas.

Montubia persona con características propias de la región litoral y zonas subtropicales poseedores de una formación cultural y política que los auto determina como resultado de un largo proceso de acondicionamiento espacio temporal que tiene su cosmovisión ancestral y mantiene su hábitat natural.

Mestiza: Resultado biológico de la combinación de grupos fenotípicos diferentes, proveniente de Europa, África y los pueblos indígenas originarios de América.

Blanca: personas cuya tonalidad de piel clara suele asociarse a poblaciones de origen europeo, aunque literalmente implica cuestiones externas como la piel clara, forma y color de cabello y ojos, entre otras.

Existen etnias que presentan riesgos perinatales específicos, independientemente de su condición socioeconómica cultural. Se puede citar a manera de ejemplo la anemia falciforme en las poblaciones afro ecuatorianas. Además de su importancia demográfica y por condiciones clínicas particulares, estos grupos poblacionales viven en condiciones de mayor vulnerabilidad que otros grupos poblacionales.

1.9 Sabe leer y escribir

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No). Tener en cuenta que la persona que solamente sabe leer o solamente escribir, se considera analfabeta.

1.10 Nivel de instrucción

Marcar con una (X) según el nivel de instrucción que corresponda. Se refiere a los estudios cursados en el sistema formal de educación.

Preguntar: ¿Cuál fue el nivel de estudios más alto al que asistió?

Educación básica jóvenes y adultos, anteriormente conocido como *Centro de alfabetización*: es el Proyecto de capacitación básica, para mayores de 15 años, sin destrezas de lectura y escritura.

Educación inicial, anteriormente conocido como *Educación Preescolar*: es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral a niños menores de 5 años.

Educación básica (preparatoria), anteriormente conocido como *Jardín de Infantes*, que corresponde al primer grado de educación.

Educación básica (elemental y media), anteriormente conocido como *Primaria (hasta sexto grado)*: comprende la educación recibida entre el primero y sexto grado.

Educación básica superior, anteriormente conocido como *Secundaria 1° a 3° curso-ciclo básico*, lo que comprende al octavo, noveno y decimo año.

Bachillerato, anteriormente conocido como *Secundaria 1° a 3° curso-ciclo diversificado*: es decir lo que significaba el cuarto, quinto, sexto curso del sistema tradicional.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including "CP. 12" and "H.E.C."

Técnico Superior³, anteriormente conocido como *Pos-bachillerato*, orientado al desarrollo de las habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores.

Superior tercer nivel de grado³, orientado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas.

Superior cuarto nivel de grado³, está orientado al entrenamiento profesional avanzado o a la especialización científica y de investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los grados académicos de maestría, PhD o su equivalente.

Ninguno: es la condición en la que la madre embarazada declara que nunca asistió a una institución educativa.

Se Ignora: cuando la madre embarazada no sabe, no responde.

Último año aprobado: registrar únicamente el año más alto que haya sido aprobado.

Preguntar: ¿Cuál fue el año más alto que aprobó en ese nivel? Categoría que deberá ser registrada a partir Educación Básica (elemental y media).

Por ejemplo: si la mujer menciona haber completado hasta el tercer año de educación básica (elemental y media), y no terminó, marcar el nivel de instrucción referido y registrar 03 en el recuadro que corresponde, lo que significaría que solo aprobó primero, segundo y tercer grado de la primaria.

1.11 Estado civil

Marcar con una (X) el estado civil que corresponda. Es importante señalar la información que la madre embarazada refiera.

Estado civil: Según el artículo 331 del Código Civil es la calidad de un individuo, en cuanto le habilita o inhabilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles.

Unión de hecho: Unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial, mayores de edad, bajo las condiciones y circunstancias que señala la Constitución de la República y la ley.

Soltera: es la persona que no ha contraído matrimonio.

Casada: es la persona que ha contraído matrimonio de acuerdo a la ley.

Divorciada: es la persona que ha disuelto su matrimonio por la vía legal.

Viuda: es la persona que sobrevive a su cónyuge y que no ha contraído nuevo matrimonio

Se Ignora: cuando la madre embarazada no sabe, no responde.

Fuente: Dirección Nacional de Estadística y Análisis de la Información, MSP.

1.12 Vive sola

Marcar con una (X) según corresponda. Corresponde a si la madre embarazada vive sola sin acompañamiento de una persona (no se refiere si la madre tiene o no pareja). Si la respuesta es positiva marcar con una (X) el casillero amarillo.

1.13 Establecimiento del control prenatal

Anotar el **unicódigo** del establecimiento de salud, en el cual está brindando la atención.

En el caso que la madre embarazada no asista con la Libreta Integral de Salud, o desconozca el lugar del control donde se realizó anteriores controles prenatales, se colocará no existe información, si la embarazada refiere el establecimiento de anteriores atenciones, colocar el unicódigo correspondiente.

Si la madre embarazada refiere el lugar de control como servicio privado, también se registrará con el unicódigo correspondiente.

Si el espacio queda en blanco, se entenderá que el profesional no registró el dato.

1.14 Establecimiento del lugar de parto

Anotar el unicódigo del establecimiento de salud en el que se atendió el parto.

Si el control prenatal y el parto se realizaron en el mismo establecimiento, entonces el unicódigo se repite en las dos variables.

Sección 2: Antecedentes familiares, personales y obstétricos

Objetivo: identificar oportunamente posibles problemas de salud, para reducir el riesgo mediante la implementación de cambios en el estilo de vida, la realización de intervenciones médicas o el incremento del monitoreo de la enfermedad.

Los datos de esta sección se obtienen al momento de la primera consulta prenatal.

Si la madre es hospitalizada (por trabajo de parto normal o enfermedad) en un establecimiento de salud diferente al lugar del control prenatal, los datos de esta sección se podrán obtener del carné perinatal o por interrogatorio directo a la madre o familiar al momento del ingreso.

ANTECEDENTES									
FAMILIARES				PERSONALES					
no	si			no	si			no	si
☐	☐	TBC		☐	☐	I	☐	Cirugía	☐
☐	☐	Diabetes		☐	☐	II	☐	Genito-Urinaria	☐
☐	☐	Hipertensión		☐	☐	G	☐	Infertilidad	☐
☐	☐	Preeclampsia		☐	☐		☐	Cardiopatía	☐
☐	☐	Eclampsia		☐	☐		☐	Nefropatía	☐
☐	☐	Otra cond.		☐	☐		☐	Violencia	☐
☐	☐	médica grave		☐	☐		☐	VIH	☐
				Cuál?					

[Handwritten signatures and stamps]

CPA 14

HFC

00000056

2.1 Antecedentes familiares

Se refiere a los antecedentes de los padres o hermanos u otros familiares consanguíneos (hasta el cuarto grado de consanguinidad).

Preguntar: **¿En su familia alguien ha tenido... (Mencionar cada una de las patologías de la Historia Clínica Materna Perinatal "Formulario 051")**. Marcar con una (X), según la respuesta que proporcione la madre embarazada.

Si existe **otra condición médica grave**, y no está registrada en el formulario, colocar en la opción **¿Cuál?** el nombre de la patología.

2.2 Antecedentes personales

Marcar con una (X), según la respuesta que proporcione la embarazada.

Se refiere a los antecedentes propios de la mujer (además de las patologías mencionadas en los antecedentes familiares, incluye otros 5 antecedentes: cirugía genito-urinaria (no incluye cesáreas), infertilidad, cardiopatía, nefropatía, violencia y VIH).

En cuanto al tema de violencia, se recomienda indagar simultáneamente tanto el antecedente como la presencia o no de violencia en el embarazo actual (ver Sección Gestación Actual).

2.3 Antecedentes obstétricos

OBSTÉTRICOS		gestas previas	abortos	vaginales	nacidos vivos	viven
ÚLTIMO EMBARAZO n/a ☐ < 2500g ☐ normal ☐ > 4000g ☐		☐ 3 espont. consecutivos	☐ cesáreas	☐ nacidos muertos	☐ muertos 1º sem. ☐ después 1º sem.	☐
Embarazos Múltiples ☐ no ☐ si						
☐ emb. molar ☐ emb. ectópico		☐ partos	☐ cesáreas	☐ nacidos vivos	☐ nacidos muertos	☐

Si se pretende reducir el riesgo reproductivo, la realización de una correcta historia puede identificar factores relacionados a complicaciones en embarazos anteriores. A veces, estos factores pueden ser corregidos o incluso eliminados, lo que debería favorecer un nuevo embarazo sin complicaciones.

La evidencia científica afirma que prolongar los intervalos intergenésicos, cesar el hábito de fumar, el uso de progesterona en caso de partos de pretérmino previos u otros medicamentos para enfermedades específicas, así como algunos tratamientos quirúrgicos, reducen el riesgo de resultados adversos maternos y neonatales.

Se ha demostrado que algunos factores como el menor espacio intergenésico, abortos espontáneos, partos pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino, muerte fetal o neonatal, parto quirúrgico, la diabetes gestacional, la hipertensión gestacional y las malformaciones uterinas integran una larga lista que puede relacionarse con la presentación de complicaciones en un nuevo embarazo.

2.3.1 Gestas previas

Se refiere al número de gestaciones anteriores, sin incluir el embarazo actual. **Anotar 00** si el presente es primer embarazo.

La paridad ha sido descrita como uno de los factores de alarma para la mortalidad perinatal y morbi mortalidad materna. La paridad elevada (cuatro o más embarazos) aumenta el riesgo de muerte fetal intraparto. Ya que este es un factor de riesgo no modificable, se deberá asesorar a las mujeres sobre los riesgos que implica una nueva gestación cuando hay multiparidad.

En caso que opte por un nuevo embarazo se deberá extremar el cuidado durante el periodo prenatal y especialmente en el parto y postparto.

Si hubo antecedentes patológicos de embarazos anteriores, ejemplo: embarazo ectópico, mola hidatiforme, colocar en el recuadro el número de embarazos correspondiente a la patología que proporciona la madre (verifique esta información con la historia clínica previa, si la tuviere disponible).

Nota: la suma de los datos del embarazo ectópico y mola hidatiforme, debe coincidir con el número de abortos y partos vaginales.

2.3.2 Partos / vaginales – cesáreas

Anotar el número de partos en el recuadro correspondiente, y de éstos cuántos fueron vaginales y cuántos por cesárea. Registrar el número en el recuadro correspondiente.

Preguntar: **¿Cuántos fueron partos vaginales y cuántos fueron por cesárea?**

2.3.3 Último embarazo

Se refiere al peso del recién nacido en el último embarazo.

Marcar con una (X), si el peso del recién nacido fue menor de 2500 gramos o si fue mayor o igual a 4000 gramos, según corresponda. Marcar (n/a) no aplica, si no hubo nacimientos previos.

2.3.4 Embarazos múltiples

En relación a las gestas previas, marcar con una (X) si hubo antecedente gemelar (Si/No), según corresponda.

2.3.5 Abortos

Es importante aconsejar a la mujer que desea un nuevo embarazo en asegurar un periodo intergenésico mayor a seis meses luego de un aborto para reducir los riesgos de enfermedad o muerte. También es relevante conocer el o los antecedentes de abortos previos. ⁴ La pérdida recurrente del embarazo, definida como la aparición de 3 abortos espontáneos consecutivos, debe orientar al profesional a una búsqueda activa de malformaciones uterinas, incompetencia cervical, defectos hormonales o incluso enfermedades infecciosas como la sífilis, caracterizadas por generar una placentitis capaz de provocar la muerte de embriones y fetos.

Anotar el número de abortos (expulsión del producto de la gestación muerto antes de las 22 semanas o con un peso menor a 500 gr) en el recuadro correspondiente, si la madre confirma que ha presentado esta condición.

Si la madre reporta haber tenido 3 abortos espontáneos consecutivos, marcar con una (X) el círculo amarillo correspondiente.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "CP-A", "HIC", and "PR"]

2.3.6 Cesáreas previas

Cuando hay antecedentes de cesáreas previas es importante conocer:

- 1.-Tipo de incisión (las incisiones tipo T comportan mayor riesgo de rotura uterina sobre las longitudinales y éstas son de mayor riesgo que las transversales segmentarias).
 - 2.- Antecedente de infección de herida quirúrgica, en especial de heridas parietales profundas que podrían provocar una cicatrización anormal que conlleve a riesgo de rotura uterina o hemorragias por placentación anormal.
 - 3.- Periodos interparto menores a 18 meses tienen mayor riesgo materno.
- Cantidad de cesáreas previas, el riesgo de rotura uterina parece estar más influido por el tipo de incisión que por el número de cesáreas.

En base a estos aspectos una madre embarazada que acude a consulta deberá ser informada sobre el mayor riesgo de rotura uterina, hemorragias por placentación anormal y advertirlas del riesgo en el uso de oxitócicos para inducir el parto, especialmente en el uso de misoprostol.

2.3.7 Nacidos vivos

Anotar el número de nacidos vivos en el recuadro correspondiente, de acuerdo a la información proporcionada por la madre embarazada.

Según el CIE 10 se *clasificará a un recién nacido vivo si muestra cualquier signo de vida después del nacimiento o de la extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo*. Se consideran signos de vida si el recién nacido respira, late su corazón, su cordón pulsa o tiene movimientos voluntarios apreciables de los músculos.

2.3.8 Nacidos muertos

Anotar el número de nacidos muertos en el recuadro correspondiente, de acuerdo a la información proporcionada por la embarazada.

Según el CIE 10 se *clasificará a un recién nacido como muerto si no evidencia signos de vida luego del nacimiento o de la extracción completa del cuerpo de su madre independientemente de la duración del embarazo*.

2.3.9 Muerte fetal previa

En la consulta preconcepcional se deberá evaluar el riesgo de repetición de la muerte fetal en un futuro embarazo para asesorar a la mujer en las posibilidades de repetir el acontecimiento y para planificar el cuidado que deberá recibir en el futuro embarazo. Hacer esta evaluación no siempre es fácil, incluso cuando se dispone del informe de necropsia del feto y la histopatología de la placenta u otros órganos. Habrá ocasiones en las que se deberá recurrir a exámenes de laboratorio como pruebas de tolerancia a la glucosa, anticuerpos anticardiolípinas y estudios específicos de la coagulación.

En un futuro embarazo podrán repetirse estos exámenes, intensificar el control prenatal, incorporar estudios ultrasonográficos morfológicos y funcionales, etc.

2.3.10 Viven

Anotar el número de hijos que están vivos al momento de la consulta.

2.3.11 Muertos 1ra semana

Anotar en el recuadro correspondiente, el número de hijos que nacieron vivos y murieron en la 1ra semana, hasta antes del séptimo día (6 días, 23 horas, 59 minutos).

2.3.12 Muertos después de 1ra semana.

Anotar en el recuadro correspondiente, el número de hijos que nacieron vivos y murieron después de la 1ra semana de vida o más.

2.3.13 Fin embarazo anterior

Anotar día, mes y año de finalización del embarazo, el anterior al actual (dd/mm/aaaa), ya sea que se trate de un parto o un aborto.

Marque el círculo amarillo en los siguientes casos:

- Intervalo entre parto previo y gestación actual menor a 1 año.
- Intervalo entre aborto previo y gestación actual menor a 1 año.

Marcar con una (X) no aplica (n/a) si se trata de una madre primigesta.

2.4 Embarazo planificado

EMBARAZO PLANIFICADO						no	☐	si	☐
FRACASO MÉTODO ANTICONCEPTIVO									
☐	☐	☐	☐	☐	☐				
Barrera	DIU	Hormonales	Natural	Quirúrgico	No usaba				

Marcar con una (X) el círculo (Si) cuando el embarazo es deseado o sucede en un momento oportuno y (No) cuando no se cumple una de las dos condiciones.

Para ayudar a identificar el embarazo no planificado preguntar: ¿Cuándo supo de este embarazo? ¿Quería estar embarazada?, ¿quería esperar más tiempo? o ¿no quería tener (más) hijos?

2.5 Fracaso método anticonceptivo

Preguntar: al enterarse de este embarazo ¿Estaba usando algún método para evitar el embarazo?

Marcar con una (X) según corresponda. (Fracaso de Método Anticonceptivo antes de embarazo actual). Las respuestas posibles están clasificadas como:

- 1.-No usaba ningún método (no usaba)
- 2.-Barrera: condón masculino, condón femenino, diafragma, capuchón cervical.
- 3.-Dispositivo Intrauterino (DIU)
- 4.-Hormonal: oral (píldoras), transdérmico (parche), anillo vaginal, implante subdérmico o inyectable.
- 5.-Anticoncepción de emergencia: Levonorgestrel solo o de estrógenos y progestina combinados.
- 6.-Métodos naturales (natural): método de día fijo, método de amenorrea por lactancia, abstinencia periódica, ritmo, Billings, entre otros.
- 7.-Quirúrgico (ligadura).

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Sección 3: Gestación actual

Objetivo: monitorear la evolución de la gestación.

- Identificar factores de riesgo, detección de patologías maternas subclínicas, para prevenir, y tratar las complicaciones del embarazo.
- Vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal.

En esta sección se encontrarán todos los datos relacionados con el embarazo actual.

GESTACIÓN ACTUAL		FUM		EG CONFIABLE por:		Ecografía
PESO INICIAL	TALLA (cm.)	día	mes	año	FUM Eco <20 s.	11-13 s.
					no ☐	no ☐
					si ☐	si ☐

3.1 Peso inicial

Se refiere al peso de la madre registrado en el primer control prenatal, independientemente de la edad gestacional.

Se recomienda a toda mujer que está planificando un embarazo, realizarse controles preconcepcionales donde se determinará el estado nutricional mediante el Índice de masa Corporal (IMC). Es aconsejable mantener un Índice de Masa Corporal (IMC) de 18.5 a 24.9, con el propósito de prevenir problemas de salud que pueden presentarse durante el embarazo.

Este dato es útil para evaluar el estado nutricional de la madre embarazada. La medida más utilizada es el Índice de Masa Corporal (IMC) que se calcula dividiendo:

Índice de Masa Corporal

$$IMC = \frac{\text{Peso (Kg)}}{\text{Altura (m)}^2}$$

El Índice de Masa Corporal (IMC) es un predictor independiente de muchos eventos adversos durante el embarazo. Las mujeres deben ser asesoradas a alcanzar un Índice de Masa Corporal (IMC) saludable antes de quedar embarazadas⁵.

3.2 Talla

Este dato requiere ser medido directamente al momento de la primera visita de control del embarazo.

La técnica de medida consiste en que la madre embarazada se ubique de pie, sin calzado, con los talones juntos, bien erguida, con los hombros hacia atrás, la vista al frente y su espalda en contacto con el tallímetro. El dato obtenido se registrará en centímetros.

3.3 Fecha de última menstruación (FUM)

Anotar en la "Historia Clínica Materna Perinatal "Formulario 051" el dato proporcionado por la embarazada, en el formato día-mes-año (dd/mm/aaaa). Preguntar: ¿Cuál fue el primer día de su última menstruación?

3.4 Fecha probable de parto (FPP) ⁵

Anotar día, mes y año de la fecha probable del parto (dd/mm/aaaa).

Para calcular la fecha probable de parto se recomienda a utilizar el gestograma diseñado por el CLAP/SMR, haciendo coincidir la flecha roja que dice: "fecha en que comenzó la última menstruación" fecha de la última menstruación y buscando la fecha correspondiente al día de la consulta se obtendrán las semanas de amenorrea.

En caso de no contar con un gestograma, se puede determinar la fecha probable de parto (FPP) mediante el uso de una de las siguientes reglas:

- Wahl: al primer día del FUM agrega 10 días y al mes le resta 3.
- Naeglele: al primer día del FUM agrega 7 días y al mes le resta 3.
- Pinard: al último día del FUM agrega 10 días y al mes le resta 3.

Si existe alguna duda sobre la edad gestacional corroborar con la primera ecografía realizada. En el caso de mujeres que ingresan para ser asistidas por un aborto y no han tenido control prenatal, no será necesario incluir la fecha probable del parto (FPP).

3.5 Confiabilidad de la edad gestacional (EG confiable por FUM, Eco<20s)

En esta variable solicita al profesional una evaluación subjetiva acerca de la confiabilidad del cálculo de la edad gestacional, ya sea por fecha de última menstruación (FUM) o por ecografía.

Cuando la fecha de la última menstruación no está disponible, una posibilidad es estimar la edad gestacional es a partir de una ecografía fetal temprana.

Registrar si la edad gestacional es considerada dato confiable a partir del dato de la fecha de última menstruación (FUM) y/o la Ecografía (SI/NO), según corresponda.

3.6 Ecografía realizada entre la (11 – 13 sem.)

Marcar con una (X), si se realiza o no ecografía entre las 11 y 13 semanas de gestación.

En los últimos años el desarrollo de nuevas investigaciones ha permitido incorporar nuevos objetivos a esta ecografía, los que pueden evaluarse adecuadamente en el primer trimestre tardío, específicamente entre la 11 y 13 semanas. De esta manera, la incorporación de la translucencia nuchal (TN) y otros marcadores de aneuploidía a la medición de la longitud céfalo-nalgas (LCN) ha modificado las exigencias de esta ecografía. A esta edad gestacional puede observarse: acrania/anencefalia, holoprosencefalia, anomalías cardíacas: principalmente con la evaluación transvaginal, onfalocele, gastrosquisis, megavejiga, displasias esqueléticas.

3.7 Fumadora activa (Fuma Act.)

	FUMA ACT.		FUMA PAS.		DROGAS		ALCOHOL		VIOLENCIA	
	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si
1 ^{er} trim.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 ^{do} trim.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 ^{er} trim.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten text: "C.P. 20"]

[Handwritten text: "H.C"]

[Handwritten text: "19"]

Marcar con una (X) la respuesta según corresponda (Si/No).

Fumadora Activa se refiere a la madre embarazada que ha fumado desde el inicio del embarazo hasta el momento de la consulta, se sugiere indagar sobre este dato por **cada trimestre** en el embarazo.

3.8 Fumadora pasiva (Fuma Pas.)

Marcar con una (X) la respuesta según corresponda (Si/No).

Fumadora Pasiva se refiere a la exposición actual de la madre embarazada, al humo del tabaco debido a que otra persona fuma en el domicilio o en el lugar de trabajo, se sugiere indagar sobre este dato **cada trimestre** en el embarazo.

Nota: el hábito de fumadora activa o pasiva afecta tanto al feto como a la madre. Entre los daños atribuidos se describen: infertilidad, aborto espontáneo, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento fetal, riesgo de parto pretérmino, desprendimiento de placenta, muerte fetal y perinatal, aumento del riesgo de infecciones del tracto respiratorio del recién nacido.

3.9 Drogas⁶

Marcar con una (X) la respuesta según corresponda (Si/No).

Se refiere al uso durante el embarazo actual, de drogas que causan dependencia como: marihuana, cocaína, anfetaminas, alucinógenos, heroína, entre otras. Éstas pueden provocar diversos riesgos en el embarazo.

3.9.1 Cocaína

Durante el embarazo puede afectar a la madre y su feto de diferentes maneras, durante los primeros meses, puede aumentar el riesgo de aborto, más tardíamente puede desencadenar un parto de pretérmino o generar una restricción de crecimiento intrauterino (RCIU), con el riesgo de provocar un recién nacido pequeño para la edad gestacional (PEG). Los niños pequeños para la edad gestacional (PEG) tienen 20 veces más probabilidades de morir en el primer mes de vida que los niños con peso adecuado. Los sobrevivientes a su vez, corren mayor riesgo de presentar discapacidades incluyendo retardo mental y parálisis cerebral. Los niños expuestos durante su vida intrauterina a la cocaína suelen tener perímetro cefálico más pequeño lo que indirectamente refleja un menor desarrollo del cerebro.

3.9.2 Marihuana

Algunos estudios sugieren que los hijos de madres que consumían marihuana durante el embarazo, tienen mayor probabilidad de presentar una restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) y de nacer prematuros, ambos aspectos favorecen la posibilidad que el niño al nacer tenga bajo peso.

Algunos niños al nacer podrían presentar excesivo llanto y temblores de forma similar al síndrome de abstinencia en los adultos.

3.10 Alcohol⁵

Marcar con una (X) si la mujer ha ingerido alcohol en este embarazo (Si/No).

Esta variable se refiere a la ingesta durante el embarazo actual de cualquier tipo de bebida con alcohol en su contenido, por ejemplo: vino, cerveza, tequila, aguardiente, whisky, aquellas bebidas tradicionales localmente, entre otras.

El alcohol atraviesa la placenta y es metabolizado muy lentamente, por lo que los niveles en la sangre del feto suelen ser mucho más altos y permanecer por mucho más tiempo que en la madre.

El consumo durante el embarazo se ha asociado con defectos psíquicos y físicos al nacer que reciben el nombre de síndrome alcohólico fetal (SAF). Éste es una de las causas más comunes de retardo mental y es totalmente prevenible. Además de los síntomas neurológicos, los niños suelen ser pequeños para la edad gestacional y tener alteraciones morfológicas características (ojos, nariz pequeños, mejillas planas) y en ocasiones algunas variedades de cardiopatía congénita.

Hay estudios que han confirmado que aún, en mujeres que consumen en forma social un promedio de dos tragos por día, pueden tener niños con menor inteligencia y mayores problemas de conducta, en comparación con los hijos de madres que no bebían.

Preguntar: Desde su última visita, ¿Ha tomado alguna bebida alcohólica?

3.11 Violencia⁵

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No).

El término violencia involucra violencia física, mental, psicológica y sexual que ocurre durante el embarazo actual. El agresor puede ser la pareja actual, parejas previas, padres u otras personas conocidas o desconocidas. Se recomienda revisar la **Norma Técnica de Atención Integral en Violencia de Género**..del Ministerio de Salud Pública.

Al respecto si un caso es detectado, se recomienda usar el siguiente modelo de interrogatorio en la primera visita prenatal:

“Permítame hacerle algunas preguntas sobre su actual relación de pareja. Sé que algunas de estas preguntas son muy personales y permítame asegurarle que sus respuestas serán completamente confidenciales:

1. En el último año, ¿alguna vez ha sido Ud. humillada, avergonzada, prohibida de ver a amigos, o hacer cosas que a Ud. le interesan?

Si la respuesta es positiva, continuar: (1ª) Desde que está embarazada ¿alguna vez ha sido Ud humillada, avergonzada, impedida de ver amigos, o hacer cosas que a Ud le interesan?

2. En el último año, ¿ha sido Ud. golpeada, o lastimada físicamente por alguien?

Si la respuesta es positiva, continuar: (2ª) Desde que está embarazada ¿ha sido Ud. golpeada, o lastimada físicamente por alguien?

3. En el último año, ¿ha sido Ud forzada a tener relaciones sexuales?

Si la respuesta es positiva, continuar:(3ª) Desde que está embarazada ¿ha sido Ud. forzada a tener actividades sexuales?

4. En el último año, ¿se ha sentido preocupada por la seguridad de sus hijos?

Si la respuesta es positiva, continuar:(4ª) Desde que está embarazada ¿se ha sentido preocupada por la seguridad de sus hijos?

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including "emb", "CP", "22", and "H.C.", along with several illegible signatures.

5. En el último año ¿ha tenido Ud. miedo de su pareja o de alguna otra persona?

Si la respuesta es **positiva**, continuar:(5^a) Desde que está embarazada ¿ha tenido Ud. miedo de su pareja o de alguna otra persona?"

Una respuesta positiva a cualquiera de las preguntas que indagan sobre violencia en el último año debe registrarse en la Sección: Antecedentes Personales. Si hay respuesta afirmativa a las preguntas relacionadas con el embarazo actual, marcar "SI" en el casillero que corresponda.

3.12 Antirubeola⁵

ANTIRUBEOLA	
previa	no sabe
☐	☐
embarazo	no
☐	☐

La eliminación de la rubéola y el síndrome de rubéola congénita (SRC) es uno de los retos pendientes en la región de las Américas. Una forma de contribuir a este esfuerzo nacional y regional es indagar en forma rutinaria sobre el estado de vacunación anti-rubéola durante el control prenatal.

Preguntar:¿Ha recibido alguna vez la vacuna contra la rubéola? Si la respuesta es afirmativa, indagar ¿Cuándo?

Marcar el casillero "previa" si recibió la vacunación en cualquier momento antes del presente embarazo. Marcar el círculo "embarazo" si la vacuna fue inadvertidamente colocada durante esta gestación; "no sabe" cuando no recuerda si recibió la vacuna; "NO" si nunca fue inmunizada. Si la madre no ha sido vacunada, la inmunización debe diferirse hasta el puerperio inmediato (antes del alta).

Marcar con una (X) el casillero según corresponda. Marcar "previa" si recibió la vacunación en cualquier momento antes del presente embarazo, "embarazo", si la vacuna fue colocada inadvertidamente en el embarazo actual, "no sabe" cuando no recuerda si recibió la vacuna, "no" si nunca fue inmunizada.

Si la madre no ha sido vacunada, la inmunización debe diferirse hasta el puerperio inmediato (antes del alta), o en el post aborto inmediato.

3.13 Antitetánica

ANTITETÁNICA	
vigente	no ☐ si ☐
DOSIS	1 ^{ra} 2 ^{da}
Mes gestación	

Marcar con una (X) la respuesta según corresponda (Si/No).

Se debe indagar el estado de vacunación al momento de la primera visita de control prenatal o durante la atención de emergencia en una mujer que acude para atención del parto o de un aborto sin control prenatal.

Es importante solicitar a las madres la tarjeta de vacunación, el carné perinatal del embarazo anterior o algún otro registro o documento en donde se pueda verificar el número y el intervalo entre dosis.

Si la madre presenta documentación revisar el número e intervalo entre dosis, así como el tiempo desde la última vacunación y decidir si debe recibir una dosis adicional.

Las madres que no poseen documentación de haber recibido inmunización contra el tétanos, deben ser vacunadas con una primera dosis en la primera consulta prenatal. La segunda dosis debe ser administrada no antes de cuatro semanas de la primera dosis o por lo menos 3 semanas antes de la fecha probable de parto.

La administración de las siguientes dosis debe seguir lo indicado en la norma nacional.

Marcar la opción "SI", si la madre:

- 1.-Recibió dos dosis y el embarazo actual está dentro de los 3 años de protección.
- 2.-Recibió tres dosis y el embarazo actual está dentro de los 5 años de protección.
- 3.- Recibió 5 dosis.

Marcar la opción "NO" en los siguientes casos, si la madre:

- 1.-No recibió ninguna dosis.

Conducta: colocar dos dosis durante el embarazo actual, la primera dosis se coloca en la primera consulta prenatal y la segunda aplicar con intervalo no mayor de 6 ni menor de 4 semanas de haberse colocado la primera dosis.

- 2.- Cuenta con información poco confiable acerca del número y fechas de administración de dosis previas.

Conducta: colocar dos dosis durante el embarazo actual.

- 3.- Recibió dos dosis y el embarazo actual se inicia después de los 3 años de protección.

Conducta: colocar únicamente una dosis (la tercera).

- 4.-Recibió tres dosis y el embarazo actual se inicia después de los 5 años de protección.

Conducta: colocar únicamente una dosis (la cuarta).

3.14 Examen normal (mamas y odontológico)

EX. NORMAL		
	no	si
MAMAS	☐	☐
ODONT.	☐	☐

Para muchas madres embarazadas, el control prenatal marca el primer contacto con los servicios de salud y por lo tanto ofrece la oportunidad de evaluar su estado en general, además del relacionado con la gestación actual. Por esta razón, la "Historia Clínica Materna Perinatal "Formulario 051" incluye variables como el examen odontológico y de mamas que refuerzan este concepto.

[Handwritten signatures and stamps]
 03/30/17
 C.P. 24
 H.C.
 [Initials]

3.14.1 Examen de Mamas

En este recuadro, el profesional debe registrar el resultado de haber realizado un examen físico manual de mamas a la madre embarazada. El momento más adecuado para realizar el examen de mama no está determinado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el examen en la tercera visita prenatal, una vez que se ha establecido confianza entre la embarazada y el servicio. Con este examen se busca identificar patología tumoral así como problemas que puedan afectar el amamantamiento posterior (como pezones invertidos o planos).

Marcar con una (X) la opción 'sí' cuando el examen de mamas sea normal y "no" en caso contrario.

3.14.2 Examen Odontológico (Odont.)

Este recuadro tiene el objetivo de verificar el cumplimiento de atención odontológica desde la primera consulta de la madre embarazada, independientemente de la edad gestacional.

El examen odontológico ha adquirido importancia por la posible asociación entre enfermedad periodontal con parto prematuro, bajo peso al nacer, preeclampsia y muerte fetal y la transmisión del *Streptococcus mutans* de la madre hacia el niño y su efecto en la incidencia de caries dental en niños pequeños.

La enfermedad periodontal incluye diagnósticos como gingivitis (inflamación de los tejidos blandos alrededor del diente) y periodontitis (destrucción de las estructuras de soporte del diente – hueso, ligamentos, cemento, etc.).

Por la importancia del diagnóstico y dando cumplimiento a la normativa, el registro de este casillero será de responsabilidad del profesional de odontología.

Marcar con una (X) la opción según corresponda (Si/No), si se realizó o no esta actividad. Si el recuadro está en blanco se evidenciará que la madre embarazada no recibió el servicio.

3.15 Cérvix

	normal	anormal	no se hizo
CERVIX Insp. visual	☐	☐	☐
PAP	☐	☐	☐
COLP	☐	☐	☐

Se debe realizar el examen vaginal con espéculo como parte de la evaluación del control prenatal con la finalidad de detectar anomalías o infecciones cervicales. *La selección del momento más adecuado para este examen es una decisión que hará el profesional tomando en cuenta la situación individual de cada madre embarazada, a través de las siguientes acciones:*

Inspección visual (Insp. visual)

Marcar con una (X) la respuesta según corresponda (anormal, normal y no se hizo). Si una anomalía cervical es observada durante el examen con espéculo, se anotará anormal en

inspección visual, si el cuello está sano se registrará normal, y en caso de no haberse efectuado el examen, se registrará no se hizo.

Papanicolaou (PAP)

Marcar con una (X) la respuesta según corresponda (anormal, normal y no se hizo).

Si se encuentra alguna anormalidad cervical o no hay seguridad que la madre embarazada pueda regresar después del parto, considerar tomar un Papanicolaou (PAP) durante el control prenatal. La interpretación de los resultados puede ser difícil cuando el Papanicolaou (PAP) es tomado durante la gestación.

Colposcopia (COLP)

Marcar con una (X) la respuesta según corresponda (anormal, normal y no se hizo). Registrar como "Normal" si la colposcopia es negativa para lesiones malignas o precursoras de cáncer cervical. De lo contrario marcar "Anormal" o no se hizo, según corresponda.

3.16 Grupo y factor Rh

GRUPO	Rh	
	-	+
	☐	☐
	no	si
Imuniz.	☐	☐

Anotar en el recuadro el **grupo sanguíneo (Grupo)** que corresponda (A, B, AB, O).

Para "Rh", marcar con un (X) en el signo positivo si la madre es Factor Rh positivo, de lo contrario marcar el signo negativo, si la madre es Rh negativo.

Si la madre está **inmunizada** (tendrá positivo el test para anticuerpos irregulares, también llamado test de Coombs indirecto) y en ese caso se marcará (Si), en caso contrario se marcará (No).

3.17 Toxoplasmosis

TOXOPLASMOSIS	
-	+
☐	☐
no se hizo	no aplica
☐	☐

Marcar con una (X) según corresponda (negativa, positiva, no se hizo) y no aplica (n/a) cuando no exista antecedentes o no presente factores de riesgo de contacto con el parásito (contacto directo con la carne cruda y las heces de los gatos).

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including "C.P." and "26".

3.18 Infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH)

VIH-Diag. tratamiento	<20 sem.		Prueba result.	TARV. en emb.	≥ 20 sem.		Prueba result.	TARV. en emb.
	solicitada				solicitada			
	si ☐	+ ☐			si ☐	+ ☐		
no ☐	- ☐	n/d ☐	no ☐	- ☐	n/d ☐	no ☐	- ☐	n/d ☐
n/c ☐	n/c ☐	☐	n/c ☐	n/c ☐	☐	n/c ☐	n/c ☐	☐

La Región de las Américas se encuentra inmersa en las estrategias globales de una generación de niños libre de VIH y sífilis congénita y en garantizar el acceso universal al tratamiento a todas las personas que viven con VIH/SIDA. Ambas estrategias intentan cumplir con parte de los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio y para ello es necesario ofrecer el tamizaje para VIH a todas las embarazadas y asegurar el tratamiento profiláctico para evitar la transmisión vertical del VIH.

Marcar con una (X) según corresponda.

Test VIH: Solicitado: SI o NO, no corresponde, anotar si el test fue solicitado/realizado antes de las 20 semanas o a las 20 semanas o más.

Prueba/ resultado: (+) o (-), no corresponde, caso contrario sin dato; si no hay información, según corresponda.

Además registrar Si o No, no corresponde, según lo indica, si la madre embarazada recibió TARV (tratamiento antirretroviral).

Prueba recomendada en cada embarazo en el primer control y a las 24 a 34 semanas.

Se ha reportado que el tamizaje temprano de VIH en el embarazo, un curso corto de fármacos antirretrovirales intraparto, cesárea a las 38 semanas de gestación y suspensión de lactancia en madres portadoras, reducen la transmisión vertical.⁷

3.19 Prueba de hemoglobina (Hb) < 20 semanas.

Hb	<20 sem.
g/dl	
<11.0g/dl ☐	

Se considera que una madre embarazada tiene anemia cuando el valor de hemoglobina es menor a 11.0 g/dl durante el primer o tercer trimestre, o cuando el valor de hemoglobina durante el segundo trimestre es menor a 10.5 g/dl. Si la hemoglobina se sitúa entre 7.0 y 10.0 g/dl se considera que la anemia es moderada y cuando es menor a 7.0 g/dl la anemia es severa.

Anotar en el recuadro correspondiente los resultados de la prueba de hemoglobina antes de las 20 semanas de gestación. En caso que los niveles sean inferiores a 11 g/dl, marcar con una (X) el círculo amarillo.

3.20 Fe/ folatos Indicados

Fe/FOLATOS	
indicados	
no	si
Fe	☐
Folatos	☐

Existe consenso en que los requerimientos de hierro y ácido fólico aumentan durante el embarazo y que es difícil que una embarazada pueda satisfacer esta mayor demanda sólo con la dieta, excepto en aquellos países en los que existen programas específicos de fortificación de los alimentos.

Las estrategias de prevención de la anemia por deficiencia de hierro se basan en:

- 1.-Modificar la dieta para aumentar el consumo de hierro y de los facilitadores de su absorción, al tiempo que se intenta disminuir el consumo de inhibidores.
- 2.-Fortalecer la dieta con alimentos ricos en hierro.
- 3.-Suplementar con medicación rica en hierro.
- 4.-Tratar aquellas infecciones que pueden alterar la absorción de hierro y otros nutrientes (por ejemplo: parasitosis).

Los suplementos de hierro han sido sugeridos como una estrategia para mejorar el estado de hierro materno y así mejorar la sobrevida y salud de la madre, el tamaño fetal, incluyendo el estado de hierro y desarrollo del niño durante el período neonatal y post-neonatal.

Marcar con una (X) según corresponda, si se indicó suplemento de hierro, marcar el círculo (SI), de lo contrario marcar en (NO).

El déficit de folatos es la segunda causa de anemia nutricional durante el embarazo y también es responsable de defectos en el cierre del tubo neural (anencefalia, espina bífida, mielomeningo y encefalocele), labio leporino, paladar hendido y otros defectos.

Marcar con una (X) según corresponda, si se indicó suplemento de ácido fólico, marcar el círculo (Si), de lo contrario marcar en (No).

3.21 Prueba de hemoglobina (Hb) ≥ 20 semanas.

Hb ≥ 20 sem.	
☐	☐
g/dl	
☐ <11.0 g/dl	

Anotar en el recuadro correspondiente los resultados de la prueba de hemoglobina después de las 20 semanas de gestación. En caso que los niveles sean inferiores a 11 gramos/decilitro, marcar con una (X) el círculo amarillo.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "CP" and "HCC", along with a date "28"]

3.22 Sífilis

SÍFILIS - Diagnóstico y tratamiento											
Prueba						Tratamiento				Tto. de la pareja	
No treponémica			Treponémica								
-	+	s/d	-	+	s/d n/c	-	+	s/d	n/c	no	si
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<20 sem			semanas			semanas				s/d n/c	
>20 sem			semanas			semanas				no si	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-	+	s/d	-	+	s/d n/c	-	+	s/d	n/c	s/d	n/c

Las pruebas de detección confirmatorias utilizadas pueden ser: no treponémicas o treponémicas. Se sugiere que las pruebas de detección se realicen en dos oportunidades, una al momento de la captación en la primera visita prenatal (antes de las 20 semanas de gestación) y otra en el tercer trimestre.

En el caso de la **prueba no treponémica**, se marcará (-) cuando la prueba no fue reactiva, (+) si fue reactiva y S/D sin dato, ésta incluye el VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) y el RPR (rapid plasma reagin). Una prueba no treponémica activa puede indicar infección actual infección reciente tratada y no tratada o un resultado falso positivo. Los resultados falsos en general tienen un título bajo. Pueden ser negativas en fases iniciales de la infección, o cuando el título es muy alto (fenómeno de prozona) y suelen negativizarse o disminuir a títulos muy bajos después del tratamiento. En los casos de sífilis tratada correctamente el VDRL tiende a negativizarse con el paso del tiempo, aunque en casos excepcionales se puede mantener positivo durante mucho tiempo (de por vida). Pueden verse falsos positivos en enfermedades autoinmunes, tuberculosis, mononucleosis, endocarditis y en el propio embarazo.

En las pruebas Treponémicas se agrega la opción (N/C) cuando no corresponda (ej.: recuerdo inmunológico de infección previa), éstas son pruebas específicas, más complejas y costosas e incluyen el TPHA (*Treponema pallidum haemagglutination assay*) y el TPPA (*Treponema pallidum particle agglutination*), y el MHATP (*microhemagglutination assay for antibodies to Treponema pallidum*) y el FTA Abs (*fluorescent treponemal antibody absorption*). Se utilizan para confirmar un resultado de una prueba no treponémica. Las técnicas más utilizadas son el MHA-TP y FTA-Abs.

Estas pruebas persisten positivas independientemente del tratamiento y pueden observarse falsos positivos (menos del 1%), en otras enfermedades por espiroquetas (leptospirosis, enfermedad de Lyme, fiebre por mordedura de ratas), en estos casos suele estar presente el antecedente epidemiológico infeccioso. Así, si una prueba treponémica es positiva y no se refiere tratamiento previo y/o no se dan las condiciones citadas se debe tratar.

Registrar (ya sea antes o después de las 20 semanas de embarazo) la semana de gestación en que fue realizada la o las pruebas. Para cada una marcar con una (X) según corresponda.

A las mujeres con pruebas reactivas se les deberá tratar, brindar asesoría e información, **conjuntamente con su pareja**, para lo cual se debe registrar con una (X) en el recuadro correspondiente, la opción Tratamiento de la pareja SI o NO, S/D sin dato, (N/C) cuando no corresponda, respectivamente.

3.27 Prevención primaria de la preeclampsia⁹

PREVENCIÓN PREECLAMPSIA		
Calcio >12 sem	no ☐	si ☐
Ácido Acetil Salicílico >12 sem	no ☐	si ☐
n/c	☐	

Se recomienda la suplementación de calcio (1,5 a 2 g de calcio elemental por día) en pacientes con alto riesgo de preeclampsia (2 o más factores de riesgo) ya que su suplementación reduce la incidencia de hipertensión gestacional y preeclampsia.

Las mujeres embarazadas con alto riesgo de preeclampsia que se pueden beneficiar de estas terapias preventivas son aquellas que tienen:

- 1.-Antecedentes de enfermedad hipertensiva gestacional previa o hipertensión crónica
- 2.-Enfermedad renal
- 3.-Enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico o síndrome antifosfolipídico o diabetes tipo 1 o 2
- 4.-Embarazos múltiples

La administración de ácido acetilsalisílico en bajas dosis (75 a 100 mg/día desde la semana 12 hasta el parto.) en gestantes con alto riesgo de preeclampsia; ha demostrado una reducción del 17% en el riesgo de preeclampsia.

- En las zonas del país donde exista alta prevalencia de enfermedades tropicales como dengue, chikungunya o zika se deberá descartar la presencia de una de estas enfermedades, previo a la administración de AINES y su manejo será por un especialista.
- En estudios realizados a niños nacidos de gestantes que recibieron ácido acetilsalisílico durante el embarazo evidencio que uso de baja dosis de este fármaco en el embarazo es seguro.

3.28 Estreptococo B 35 - 37 semanas

ESTREPTOCOCO B 35-37 semanas		
☐	☐	☐
-	+	no se hizo

La infección por Estreptococo grupo B es considerada una causa importante de morbilidad y mortalidad neonatal.

La estrategia principal para disminuir esta infección en los recién nacidos es la detección durante el embarazo del estreptococo del grupo B (entre las 35 y 37 semanas) a través de la medición mediante hisopado vaginal y rectal.

Marcar con una (X) según corresponda (negativo, positivo, no se hizo).

3.29 Educación Prenatal

EDUCACION PRENATAL-Sesiones					
☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	2	3	4	5	6

El término educación prenatal tiene varios significados e incluye conceptos variados como: informar a la madre embarazada y su familia acerca de los cambios que ocurren en la gestación y aquellos esperados durante el parto y el puerperio; preparar a los padres para enfrentar mejor su nuevo rol; preparar un plan de parto; entrenar en psicoprofilaxis (técnicas de relajación y respiración); aumentar la percepción de autocontrol de la mujer, entre otros.

En primigestas el embarazo y el nacimiento de un niño/a pueden generar muchos temores, dudas e inseguridades, condiciones que el personal de salud debe abordar, con el fin de procurar el bienestar de la madre, su pareja y el recién nacido.

Es importante que tanto la mujer como su pareja consideren el embarazo como un proceso natural, que hay que vivir con placer, satisfacción y expectativas positivas de cambio. Aun así, el embarazo, el parto y el puerperio no son situaciones exentas de riesgos y en muchos casos, si estos peligros o problemas se detectan a tiempo, se pueden reducir o resolver adecuadamente.

Marcar con una (X), en cada una de las sesiones conforme se desarrollen, considerando que el mínimo son 6 sesiones, la primera sesión debe realizarse a las 20 semanas de gestación, y de esta manera cumplir con las sesiones requeridas, hasta máximo las 38 semanas, llevadas a cabo cada 15 días, con una duración de 2 horas cada una, y un máximo de 6 a 10 participantes.

Si el espacio está en blanco, significará que la embarazada, no pudo acceder a la Educación Prenatal (refiérase a la **Norma Técnica de Educación Prenatal, MSP, 2015**).

Nota: este es el momento oportuno para recordar a la madre embarazada los derechos que le asisten a ella y su recién nacido/a, según la legislación nacional y los acuerdos internacionales firmados por el país.

3.30 Plan de parto y emergencia

PLAN DE PARTO Y EMERGENCIA	
no ☐	si ☐

Marcar con una (X) la opción (Si) cuando se realiza el plan de parto ó (No) cuando no se realiza el plan de parto.

Nota: realizar el plan de parto y emergencia, en el primer control prenatal, el cual consiste en dar asesoría a la madre y su familia, con el objetivo de preparar las condiciones para el cuidado del embarazo, parto, puerperio y el recién nacido/a, apoyados por el personal de salud, sociedad civil y comunidad organizada, y de esta manera fomentar el parto institucional.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "C.P. 32", "HCC", and "PP"]

3.31 Consejería en lactancia materna

CONSEJERÍA LACTANCIA MATERNA	
no ☐	si ☐

Se sugiere proporcionar consejería sobre lactancia materna, entendiéndose por consejería la entrega clara, entendible, normatizada y oportuna de la siguiente información:

- Beneficios de la leche materna y los riesgos de la alimentación con leche artificial.
- Técnicas de Lactancia Materna.
- Los cambios en la leche materna después del parto y
- Discutir las dudas y preguntas de la embarazada.

También es necesario informar en este momento sobre los derechos del niño. Si la madre embarazada ha recibido consejería en lactancia materna tal como se definió, se registrará según corresponda (SI/NO).

3.32 Controles prenatales

La "Historia Clínica Materna Perinatal "Formulario 051" contiene espacio para 5 controles prenatales.

CONTROLES PRENATALES	día	mes	año	Edad gest.	Peso	Ganancia adecuada peso	TA	FC	FR	T°C	Sat.	Protei- nuria	Est. conc.	Altura uterina	Presen- tación	FCF (lpm)	Movim. fetales	Sangrado vaginal
							no ☐ si ☐											
						no ☐ si ☐												no ☐ si ☐
						no ☐ si ☐												no ☐ si ☐
						no ☐ si ☐												no ☐ si ☐
						no ☐ si ☐												no ☐ si ☐

Nota 1: si requiere más espacios para nuevos controles, registrar todos los datos en la nota de evolución de la historia clínica, formulario 005.

Los datos para registrar son:

- 1.-Día, mes y año de la consulta, en el orden correspondiente día, mes, año (dd/mm/aaaa).
- 2.-Edad gestacional, al momento de la consulta en semanas completas.
- 3.-Peso, en kilogramos, colocar en el recuadro tres dígitos, ejemplo: 52.1 Kg.
- 4.-Ganancia adecuada de peso: marcar con una (X) la opción que corresponda (Si/No)

5.-**Tensión arterial (TA)**, el uso del brazalete del tamaño adecuado para la medición de presiones de la madre embarazada es de vital importancia para obtener datos exactos de la presión arterial especialmente durante el embarazo y el posparto. La disminución en la tensión arterial debe ser considerada como un signo tardío de deterioro [peri mortem], las mujeres embarazadas pueden perder hasta un 30-40% de su volumen de sangre circulante sin cambiar a sus signos vitales, especialmente su presión arterial.

6.-**Frecuencia cardiaca**: se recomienda tomar la frecuencia cardiaca de forma manual, de no ser posible se puede usar el oxímetro de pulso digital.

7.-**Frecuencia respiratoria**: es el indicador más sensible del deterioro del estado fisiológico normal y es necesario documentar en cada medición de signos vitales. La frecuencia respiratoria es el primer indicador de que existe un problema o deterioro en la condición de la madre embarazada.

8.-**Temperatura**: es significativa en una madre embarazada, así como durante el puerperio. Se recomienda medir la temperatura de forma regular, y con mayor frecuencia en madres embarazadas con síntomas y signos de infección.

9.-**Saturación**: La saturación de oxígeno se supervisa de forma rutinaria en mujeres embarazadas y posparto, ya que determina la gravedad de una enfermedad, para un adecuado aporte de oxígeno al feto, la saturación materna debería estar por encima del 95% y la PO₂ por encima de 70 mm de Hg.

10.-**Proteinuria**: anotar el signo (+) si se detecta albúmina o proteínas en la orina, dependiendo de la cantidad de proteína detectada (++) / (+++), o el signo (-) si no contiene proteínas.

Si deja la casilla en blanco se interpretará como (no se hizo). La proteinuria medida en tirilla o medida en orina de 24 horas, en una madre embarazada con edad gestacional mayor a 20 semanas es un signo significativamente importante para la detección del riesgo.

11.-**Estado de conciencia**: El nivel de conciencia debe ser evaluado en todas las madres embarazadas. Una alerta de gravedad se desencadena dependiendo el puntaje:

Alerta y consciente = 0

Responde a la voz = 1

Responde al dolor = 2

No responde = 3

12.-**Altura uterina**: en centímetros, consiste en medir la distancia entre el hueso púbico (sínfisis pubiana) y el fondo de útero, usando una cinta métrica.

13.-**Presentación**: identificación de cuál de los dos polos fetales se pone en proximidad o en contacto con la pelvis menor, por ejemplo: cefálica (cef), pelviana (pel), incluye la situación transversa (tra) y oblicua (obli).

En aquellas situaciones que por la edad gestacional no aplique efectuar alguna de estas presentaciones (por ejemplo, presentación fetal antes de las 28 semanas), se anotará NC (no corresponde).

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller ones.

14.-Frecuencia cardíaca fetal: latidos fetales por minuto (FCF/l pm).

15.-Movimientos fetales: registrar el signo (+) o (-), según corresponda. La falta de datos se interpretará como actividad no realizada.

16.-Sangrado Vaginal: marcar con una (X) según corresponda, SI o NO a la presencia o ausencia de sangrado vaginal en los controles prenatales.

17.-Exámenes, tratamientos, cálculo de SCORE MAMÁ (anotar información relevante si la hubiere, además del puntaje calculado del SCORE MAMÁ), de lo contrario solo el puntaje mencionado.

18.-Iniciales Técnico: se refiere a las iniciales del profesional de salud que realizó el control prenatal a la mujer embarazada, por ejemplo: Luis Andrés Pérez Martínez = LAPM.

19.-Fecha de próxima cita: en el orden correspondiente día, mes, año (dd/mm/aaaa).

3.33 Score MAMÁ

Considerando que el embarazo y el trabajo de parto son eventos fisiológicos normales, el observar los signos vitales es parte integral de la atención.

Es posible que cualquier madre gestante o durante el posparto presente riesgo de deterioro fisiológico, y que no siempre se puede predecir. La detección temprana de la enfermedad grave en las madres es aún desafío para los profesionales involucrados en su cuidado.

El registro y documentación regular de signos vitales ayudarán al reconocimiento temprano de cualquier cambio en la condición de una madre, y proveerán a tiempo el tratamiento necesario según sea el caso.

El sistema de puntuación de alerta temprana de morbilidad materna (SCORE MAMÁ) fue desarrollado con el objetivo de clasificar la gravedad de las pacientes gestantes y puérperas, y precisar la acción necesaria y oportuna para la correcta toma de decisiones, mediante el uso de una herramienta objetiva.¹⁰

Consta de 6 (seis) signos vitales, y 1 (un) signo cuantitativo los mismos que fueron mencionados anteriormente:

- 1.-Frecuencia Cardíaca (FC)
- 2.-Presión arterial dividida en
 - Sistólica
 - Diastólica
- 3.-Frecuencia Respiratoria (FR)
- 4.-Saturación de oxígeno (Sat)
- 5.-Estado de Conciencia
- 6.-Proteinuria

Cada signo vital, tiene una puntuación asignada que va de 0 a 3 a la izquierda y derecha respectivamente. Dependiendo de la variabilidad de los signos vitales se les ha asignado un puntaje, altamente sensible para detectar a tiempo las gestantes o mujeres posparto con riesgos de morbilidad.¹¹

SCORE MAMÁ									
Puntuación	3	2	1	0	1	2	3	Puntuación	TOTAL
FC	≤ 50	—	51-59	60-100	101-110	111-119	≥ 120	FC	
Sistólica	≤ 70	71-89	—	90-139	—	140-159	≥ 160	Sistólica	
Diastólica	≤ 50	51-59	—	60-85	86-89	90-109	≥ 110	Diastólica	
FR	≤ 11	—	—	12-22	—	23-29	≥ 30	FR	
T (°C) (*)	—	≤ 35.5	—	35.6-37.2	37.3-38.4	—	≥ 38.5	T (°C)	
Sat (**)	≤ 95	86-89	90-93*	94-100	—	—	—	Sat	
Estado de Conciencia	—	confuso / agitada	—	alerta	responde a la voz / somnoliento	responde al dolor / estupefacto	no responde	Estado de Conciencia	
Proteinuria (***)	—	—	—	(-)	(+)	—	—	Proteinuria	
La adecuada toma de signos vitales puede salvar una vida.								TOTAL SCORE MAMÁ	

Considere que en la labor de parto los valores de signos vitales podrían alterarse

(*) Temperatura axilar

(**) La saturación de 90 a 93% en pacientes que viven sobre los 2.500 metros, sobre el nivel del mar tendrán un puntaje de 0

La Saturación se tomará sin ayuda de oxígeno suplementario.

(***) Sobre las 20 semanas de gestación

La suma de puntos se anota en la columna lateral derecha, misma que facilita el conteo. El puntaje se calcula dependiendo del valor en el signo vital obtenido en la medición de signos vitales de la mujer embarazada o posparto.

Pasos a seguir dependiendo de la puntuación obtenida SCORE MAMÁ- Nivel ambulatorio.

0	EVALUAR Y ANALIZAR FACTORES DE RIESGO, BIENESTAR MATERNO-FETAL Y SIGNOS DE ALARMA
1	EVALÚE Y ANALICE FACTORES DE RIESGO 1. Aplique Score MAMÁ c/4 horas y registre. 2. Reevalúe signos vitales. 3. Evalúe factores de riesgo y signos de alarma materna 4. Realice pruebas de bienestar fetal básicas utilizando estetoscopio, doppler fetal o campana de Pinar. 5. Considere exámenes complementarios y/o evaluación por interconsulta con especialista 6. Si revierte puntaje envíe a la casa y realice seguimiento (Agendamiento).
2-4	TRATE Y REFIERA SEGÚN EL CASO 1. Aplique Score MAMÁ c/ hora y registre. 2. Reevalúe signos vitales más signos de alarma. 3. Realice un diagnóstico primario basado en las Guías de Práctica Clínica. 4. Realice pruebas de bienestar fetal básicas utilizando (estetoscopio, doppler fetal o campana de Pinar) 5. Aliste, active y aplique D.E.R.: AZUL, o ROJO según sea el caso. 6. Elabore hoja de referencia (053) y envíe a nivel de capacidad resolutoria según el caso. 7. Transfiera (acompañada por un profesional de salud). 8. Active cadena de llamadas: comuníquese a Director de la unidad y éste al Director Distrital. 9. Realice el seguimiento del caso.
≥ 5	TRATE Y REFIERA SEGÚN EL CASO 1. Aplique Score MAMÁ c/ 30 minutos y registre. 2. Reevalúe signos vitales más signos de alarma 3. Realice pruebas de bienestar fetal básicas utilizando estetoscopio, doppler fetal o campana de Pinar. 4. Aliste, active y aplique D.E.R.: AZUL, o ROJO según sea el caso del diagnóstico primario basado en las Guías de Práctica Clínica. 5. Elabore hoja de referencia (053) y envíe a establecimiento de salud de mayor complejidad según la emergencia obstétrica. 6. Transfiera acompañada por un profesional de salud. 7. Active cadena de llamadas: comuníquese a Director de la unidad y éste al Director Distrital o Zonal. 8. Realice el seguimiento del caso.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "CP" and "HCC", along with a date "36".

Fuente: Ministerio de Salud Pública, Ecuador, Instructivo de implementación Estrategia "ALARMA MATERNA" en el Ecuador, 2016.

Sección 4: Parto / Aborto

Objetivo: Evidenciar las condiciones en las que ocurre el parto o aborto, su manejo adecuado y las intervenciones implementadas en el caso de presentarse alguna complicación.

Esta sección está diseñada para registrar los datos relevantes del trabajo de parto, parto y aborto.

PARTO ☐ ABORTO ☐	
FECHA DE INGRESO día mes año 	
CARNÉ no ☐ sí ☐	CONSULTAS PRENATALES total
	HOPITALIZACIÓN EMBARAZO no ☐ sí ☐ días

Nota 1: En caso de **ABORTO** anotar únicamente el Sexo, Malformaciones, Peso y Longitud al Nacer. Algunos abortos serán a muy temprana edad y no permitirán el registro de estos datos. En este caso, colocar las siglas n/a (no aplica); pero asegurarse de anotar en Nacimiento: Muerto – Ignora el Momento y la Edad Gestacional a la expulsión, además anotar la puntuación de APGAR 1^{er} min 00 y al 5^{to} min 00.

Nota 2: En caso de **Muerte Fetal** anotar sexo, malformaciones, peso y longitud al nacer, edad y asegurarse de anotar en Nacimiento: Muerto – Anteparto o Parto (según corresponda) y la Edad Gestacional al parto.

Marcar con una (X) la casilla respectiva según corresponda (parto o aborto). Este dato es un indicador de calidad del registro.

4.1 Fecha de ingreso

Anotar en el recuadro el día-mes-año (dd/mm/aaaa), correspondiente a la fecha de ingreso de la madre embarazada al establecimiento de salud.

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No), si la madre embarazada presenta o no el **carné perinatal**, al momento de la hospitalización para el parto o el aborto, con el objetivo de tener una constancia de los controles prenatales y detalles indispensables de la evolución del embarazo.

4.2 Consultas prenatales total

Si la madre embarazada presenta el carné perinatal, contar el número total de consultas prenatales y anotar en la "Historia Clínica Materna Perinatal "Formulario 051", en el recuadro correspondiente.

En caso de que la madre embarazada no presente el carné perinatal, preguntar: **¿Se hizo control prenatal alguna vez?** Si la respuesta es negativa, registrar 00. Si la respuesta es afirmativa, continuar: **¿Cuántos controles prenatales tuvo?** y registrar el dato reportado.

4.3 Hospitalización en el embarazo

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No). Se refiere a hospitalizaciones ocurridas por razones diferentes al parto. Si han existido hospitalizaciones durante el embarazo, se registrará el círculo amarillo que indica si, en ese caso también se deberá registrar el

número total de días de hospitalización, (de la única internación o la suma de días de todas las internaciones).

4.4 Corticoides antenatales

CORTICOIDES ANTENATALES	
completo ☐	 semana inicio
incompl. ☐	
ninguna ☐	
n/a ☐	

La variable corticoides antenatales, además de fundamentarse en su probada efectividad para la maduración fetal, intenta ser un recordatorio para aumentar su uso por parte de los profesionales. Siendo además un indicador que permite monitorizar calidad de atención perinatal.

Marcar con una (X) según corresponda:

1.-Completo: Si la madre embarazada recibió dos dosis de 12 mg de betametasona. por vía intramuscular administradas cada 24 horas; o cuatro dosis de 6 mg de dexametasona por vía intramuscular administradas cada 12 horas.

2.-Incompleto: cualquier variación en menos con el esquema descrito.

3.-Ninguna: No recibió ninguna dosis de corticoides

4.-No aplica: Cuando no está indicada su administración.

Semana de inicio: Registrar las semanas de gestación al momento de administrar la primera dosis.

4.5 Uteroinhibidores

UTEROINHIBIDORES	
si ☐	 semana inicio
no ☐	
n/a ☐	

Marcar con una (X), (Si, No) según corresponda, si se administró sustancias dirigidas a inhibir las contracciones del miometrio, antes de las 37 semanas de gestación. Anotar en el recuadro correspondiente las semanas de gestación al momento de administrar la primera dosis de uteroinhibidores.

No aplica: en los embarazos de transcurso normal, a término.

4.6 Inicio

INICIO
espontáneo ☐
inducido ☐
cesárea ☐

embarazo
c.p. 38
Hic
PR

Se refiere al inicio del trabajo de parto. Marcar con una (X) según corresponda (Espontáneo, Inducido, Cesárea).

4.7 Ruptura de Membranas Anteparto

RUPTURA DE MEMBRANAS ANTEPARTO					
no ☐	día mes año <37 sem ☐				
si ☐	día mes año ≥18 hs. ☐				
		hora	min	temp ≥ 38°C ☐	

Se identifica por la pérdida de líquido amniótico antes que haya empezado el trabajo de parto, independientemente de la edad gestacional.

Si se confirma rotura de membranas antes del inicio del trabajo de parto, registrar el momento aproximado del inicio de la pérdida de líquido amniótico (fecha y hora/min). Marcar los espacios en amarillo si la pérdida se inició antes de las 37 semanas, si el tiempo de pérdida es mayor o igual a 18 horas y si se acompaña de temperatura (Temp > 38°C).

4.8 Edad gestacional al parto

EG AL PARTO / ABORTO	
semanas	días
por FUM ☐	por Eco ☐

Anotar en el recuadro la edad gestacional al momento del parto en semanas completas y días y marcar con una (X) si el cálculo se basó en la fecha de última menstruación (FUM) y/o en la ecografía (ECO).

4.9 Presentación / situación

PRESENTACIÓN SITUACIÓN	
cefálica	☐
pelviana	☐
transversa	☐

Marcar con una (X) según el tipo de presentación / situación según corresponda: "cefálica", "pelviana" o "transversa", diagnosticada en el momento del inicio del trabajo de parto.

4.10 Peso producto (aborto)

PESO PRODUCTO (aborto)	
g	
n/a ☐	

Registrar en gramos el peso del producto en el caso de un aborto. Variable que contribuye al análisis epidemiológico de la mortalidad perinatal, así como para el registro del certificado de defunción.

Marcar (n/a) no aplica, si no se trata de un aborto.

4.11 Tamaño fetal acorde a edad gestacional (EG)

TAMAÑO FETAL ACORDE EG	
no ☐	si ☐

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No), si el tamaño fetal estimado por maniobras clínicas y las semanas de edad gestacional concuerdan.

4.12 Acompañante

ACOMPANANTE					
	Pareja	Familiar	Partera/o	Otro	Ninguno
TDP	☐	☐	☐	☐	☐
P	☐	☐	☐	☐	☐

Esta variable está basada en primer lugar en el derecho que tiene toda madre embarazada a permanecer acompañada por quien ella elija y en segundo lugar porque existen evidencias científicas que indican mejores resultados clínicos en las madres embarazadas que efectivamente tienen acompañamiento, refiérase a la **Guía de Práctica Clínica Atención del trabajo parto, parto y postparto inmediato, MSP, 2015**.

Registrará la presencia durante el trabajo de parto (TDP) y/o parto (P) de una persona (pareja, familiar, partera/o, otro) que ofrece apoyo emocional, información, aliento y confort, en forma continua e individualizada a la madre embarazada.

No debe considerarse 'acompañante' al personal de salud que estuvo presente realizando únicamente evaluación clínica o administrando tratamientos.

Marcar con una (X) según corresponda. Señalar NO APLICA únicamente cuando la madre acude al servicio de salud sin acompañante, es decir sola. Se deberá verificar siempre preguntando, "¿alguien le está acompañando, le gustaría que pase a la sala de parto?".

4.13 Prácticas interculturales ¹²

PRÁCTICAS INTERCULTURALES				
Vestimenta	Entrega placenta	Ingesta líquidos	Otras	
si ☐	☐	☐	☐	
no ☐	☐	☐	☐	
Cuál? _____				

011

ambos
40
M-PC

Handwritten signatures and marks.

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No), si se realizó las siguientes actividades:

- 1.-**Vestimenta:** se permitió la utilización de vestimenta propia (no bata hospitalaria).
- 2.-**Entrega de placenta** (a solicitud de la embarazada).
- 3.-**Ingesta de líquidos claros:** agua, zumos de frutas sin pulpa, café y té sin leche, bebidas energéticas.
- 4.-**Señalar otra**, en el caso de haber realizado otra actividad y detallar específicamente que práctica se hizo.

4.14 Posición parto¹²

POSICIÓN PARTO	
arrodillada ☐	de pie ☐
cucullas ☐	sentada ☐
acostada de lado ☐	litotómica ☐

Marcar con una (X) según corresponda: arrodillada, cucullas, acostada de lado, de pie, sentada y litotómica (ginecológica), ésta debe ser una elección de la madre si lo desea, más no debe ser rutinaria.

Las posiciones verticales o laterales, comparadas con supina o de litotomía, se asocian a una menor duración de la segunda etapa de parto, menos nacimientos asistidos, tasas menores de episiotomías, menor dolor agudo durante la segunda etapa y menos patrones anormales de la frecuencia cardíaca fetal.

4.15 Nacimiento

NACIMIENTO				
VIVO ☐				
día	mes	año	hora	min
MUERTO ☐		Parto ☐		
		Anteparto ☐		
		Se ignora ☐		

Se refiere al estado vital del recién nacido al momento del parto. Marcar con una (X) según corresponda: Vivo o muerto (anteparto, parto, o ignora el momento).

4.16 Fecha y hora del nacimiento

Anotar en el recuadro correspondiente la hora y minutos del nacimiento, así como el día, mes y año, en el formato dd/mm/aaaa.

4.17 Múltiple (nacimiento múltiple)

MÚLTIPLE		orden
no ☐	si ☐	

Anotar si el nacimiento corresponde a un nacimiento múltiple (Si/No). En caso de ser múltiple anotar el orden del nacimiento en el rectángulo correspondiente. En caso de no ser un embarazo múltiple anotar 0 en el rectángulo "orden".

Nota : En caso de nacimientos múltiples debe llenarse una HCMP individual para cada recién nacido.

4.18 Terminación

Marcar con una (X) según corresponda (espontánea, cesárea, fórceps, vacuum u otra).

TERMINACIÓN	
espont. ☐	cesárea ☐
fórceps ☐	vacuum ☐ otra ☐

4.19 Indicación principal de inducción o parto operatorio

INDICACIÓN PRINCIPAL DE INDUCCIÓN O PARTO OPERATORIO	INDUC. CIE 10				
	OPER. CIE 10				

Anotar la causa o causas por las que se indicó la inducción, cesárea, fórceps, o vacuum. Y anotar en el recuadro según codificación CIE-10(4 dígitos).

4.20 Episiotomía

EPISIOTOMÍA	
si ☐	no ☐

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No). No se recomienda practicar episiotomía de rutina en el parto espontáneo. La limitación del uso de la episiotomía a indicaciones estrictas tiene una serie de beneficios: menos traumatismo perineal posterior, menos necesidad de sutura y menos complicaciones. Si bien la episiotomía puede aumentar el riesgo de traumatismo perineal anterior, no provoca una reducción en la mayoría de las medidas de dolor y de traumatismo perineal o vaginal severos.¹³

4.21 Desgarros (grado 1 a 4)

DESGARROS	no ☐	Grado (1 a 4)
	☐	

Marcar con una (X) si hubo o no desgarro perineal. Si lo hubo anotar en el recuadro correspondiente el grado respectivo (1a 4).

Desgarro Grado 1: Lesión de piel perineal

Desgarro Grado 2: Lesión del músculos del periné sin afectar el esfínter anal

Desgarro Grado 3: Lesión del esfínter anal

Handwritten signatures and stamps, including a date stamp "4/4" and a stamp "C.P. 42".

Desgarro Grado 4: Lesión del esfínter anal y la mucosa rectal.

4.22 Manejo activo (oxitócicos)

MANEJO ACTIVO	
no ☐	si ☐

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No)

Marcar SI cuando se realice las actividades de la tercera etapa de la labor de parto: Administración de oxitocina 10 UI intramuscular dentro del primer minuto después del parto del recién nacido o 5 UI intravenosas administradas lentamente/o ergometrina 0.2 mg intramuscular, tracción y contra tracción controlada del cordón umbilical; masaje uterino.¹⁴

No administre ergometrina a mujeres con preeclampsia, eclampsia o presión arterial elevada porque aumenta el riesgo de convulsiones y accidentes cerebro vasculares).

Marcar No cuando no se hayan realizado las actividades del manejo activo.

4.23 Placenta

PLACENTA	
	no ☐ si ☐
completa ☐	☐
retenida ☐	☐

Marcar con una (X) según corresponda; si la placenta se ha expulsado completa (Si/No) o se ha quedado retenida (Si/No).

4.24 Ligadura del cordón al cesar pulsaciones

LIGADURA CORDÓN AL CESAR PULSACIONES	
no ☐	si ☐

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No), cuando se realiza la ligadura del cordón umbilical al cesar las pulsaciones.

4.25 Recibió

RECIBIÓ	Inducto conducción	Oxitócicos en TDP	Antibiot	Analgesia	Anest. local	Anest. región	Anest. gral.	Transfusión	Sulfato de Mg. preeclam. eclam.	
no ☐	no ☐	no ☐	no ☐	no ☐	no ☐	no ☐	no ☐	no ☐	no ☐	☐
si ☐	si ☐	si ☐	si ☐	si ☐	si ☐	si ☐	si ☐	si ☐	si ☐	☐

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No), se refiere a la medicación administrada durante el trabajo de parto o parto.

La lista incluye:

- 1.-**Inducto conducción** (misoprostol, prostaglandinas, oxitocina)
- 2.-**Oxitócicos en trabajo de parto** (oxitócicos en TDP)
- 3.-**Antibióticos** (antibiot)
- 4.-**Analgesia**, se refiere al uso de analgésicos intravenosos.
- 5.-**Anestesia local** (anest.local), corresponde a la infiltración del periné con anestésicos locales.
- 6.-**Anestesia regional** (anest. región.), incluye la analgesia peridural, raquídea y mixta.
- 7.-**Anestesia general** (anest. gral).
- 8.-**Transfusión**, se refiere a sangre entera o hemoderivados (glóbulos, plaquetas, plasma).
- 9.-**Sulfato de Magnesio**, se refiere a la administración del medicamento durante el trabajo de parto o parto, como tratamiento de preeclampsia / eclampsia.

4.26 Medicación

Medicación	no ☐	si ☐
Cuá?		

Marcar con una (X) la casilla que corresponda, se refiere si se administró otro tipo de medicamento durante el trabajo de parto, y el parto, si la respuesta es afirmativa indicar qué se administró.

Sección 5: Morbilidad

5.1. Trastornos hipertensivos

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS		
	no ☐	si ☐
Eclampsia	☐	☐
HELLP	☐	☐
Transitoria	☐	☐
Previa con proteinuria sobreagregada	☐	☐
Previa	☐	☐
Preeclampsia	☐	☐

Trastornos Hipertensivos es una variable resumen. Se debe marcar SI en caso que haya registrado, si, en al menos una de las variables de la sección. Cuando no haya marcado ninguna se anotará NO.

Las variables de la sección son:

- **Eclampsia**

Se refiere a si la madre embarazada con preeclampsia presenta convulsiones y/o estado de coma, se marcará el círculo amarillo que indica eclampsia SI, en caso contrario se anotará NO.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller ones, some with dates like 4/4.

- **Síndrome Hellp**

Una madre embarazada con preeclampsia que presente cualquiera de los siguientes signos será considerada portadora de un síndrome de Hellp y en ese caso se marcará el círculo amarillo que dice SI.

Los signos de Hellp son:

- Plaquetas < a 100.000 por centímetro cúbico.
- Láctico Deshidrogenasa (LDH) > 600 UI/litro.
- Aspartato Amino Transferasa (AST) > 70 UI/litro.
- Alanino Amino Transferasa (ALT) > 70 UI/litro.

De no tener estos valores de laboratorio alterados, se marcará NO.

- **HTA Transitoria**

Una madre embarazada que presente hipertensión que comienza después de la semana 20 de gestación, o después del trabajo de parto, o durante las primeras 24 horas del puerperio y desaparece antes del día 10 del puerperio, y que no se acompaña de proteinuria. En ese caso se marcará el círculo amarillo que dice SI. De no tenerla presente, se marcará NO.

- **HTA previa con proteinuria sobre agregada**

Una madre embarazada que presente hipertensión previa al embarazo y que tenga proteinuria sobre agregada. En ese caso se marcará el círculo amarillo que dice SI. De no presentarla, se marcará NO.

- **En caso de previa.**

La hipertensión previa puede ser Leve o Grave. Se considera Leve en el estado temprano de la enfermedad cardíaca hipertensiva, en la cual hay presión arterial reproducible de 140-159 mm Hg de sistólica y 90 – 109 mm Hg de diastólica. Se considera grave en caso que la paciente presente cifras mayores a esta o existan signos asociados de encefalopatía hipertensiva y/o lesiones de órganos blancos.

- **Preeclampsia grave**

Cuando la madre embarazada presente presión sistólica mayor o igual a 160 mm Hg, presión diastólica mayor o igual a 110 mm Hg o proteinuria mayor o igual a 5 g en orina de 24 horas se marcará SI.

También se marcará SI, cuando además de los signos precedentes exista cualquiera de los siguientes criterios:

- Oliguria menor a 0,3 cc /Kg/hora en 6 horas (menos de 500 cc /día).
- Creatinina aumentada.
- Sin mediciones inminentes de eclampsia (fosfenos, acufenos, cefalea, epigastralgia, visión borrosa u otras alteraciones cerebrales o visuales).
- Edema pulmonar y/o cianosis.
- Plaquetas < a 150.000 por cc.
- Hemoglobina aumentada en estados de hemoconcentración o disminuida en estados de hemólisis.
- Tiempo Parcial de Tromboplastina (PTT) prolongado.
- Razón Internacional Normalizada (INR) prolongado.
- Aspartato Amino Transferasa (AST) > 40 UI/L y menor de 70 UI/L.
- Alanino Amino Transferasa (ALT) > 40 UI/L y menor de 70 UI/L.
- Láctico Deshidrogenasa (LDH) > 400 y menor de 600 UI/L.
- Bilirrubinas aumentadas.

Cuando no esté presente ninguno de los signos mencionados se marcará NO.

5.2. Infecciones

INFECCIONES					
no ☐		si ☐			
SIRS	☐	☐	Neumonía	☐	☐
Sepsis	☐	☐	Mastitis	☐	☐
Endometritis	☐	☐	Gonoreya	☐	☐
Infección ovular	☐	☐	Parasitosis	☐	☐
Infección genital	☐	☐	Infección herida cesárea	☐	☐
Bacteriemia asintomática	☐	☐	Infección episiorrafia	☐	☐
Pielonefritis	☐	☐	Otra infección	☐	☐

Infecciones es una variable resumen. Marcar SI en caso que haya marcado SI en al menos una de las variables de la sección. Cuando no se haya marcado ninguna se anotará NO.

Las variables de la sección son:

- **Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS)**

Corresponde a la sigla en inglés que identifica el Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica. Una agrupación de signos clínicos y de laboratorio producto de la activación del sistema inmune en respuesta a un grupo variado de noxas (infecciones, traumatismos, etc.). Se considera que una madre embarazada tiene Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS) cuando presenta al menos dos de los siguientes signos:

- Frecuencia Cardíaca (FC) > 90 lpm
- Frecuencia Respiratoria (FR) > 20 rpm
- Temperatura > 38° C o < 36° C
- PaCO₂ < 32 mm Hg
- Leucocitos > 12000 o < 4000
- Neutrófilos en cayado > 10% (desviación a izquierda)

De presentar dos o más de los signos citados se marcará el círculo amarillo que indica SIRS SI, en caso de no haber ningún signo de Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS) o sólo uno de ellos, se anotará NO.

- **Sepsis**

La presencia de un Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS) con un foco infeccioso ostensible será catalogada como sepsis y se marcará SI, en caso que no haya evidencia de sepsis se marcará NO.

- **Endometritis**

Toda endometritis, no importa su origen (

complicación de un embarazo, aborto o parto), deberá ser considerada. Se interpretará que la paciente es portadora de una endometritis cuando tenga un cuadro clínico caracterizado por fiebre, sensibilidad uterina, loquios alterados en cantidad, composición, fétidos,

Handwritten notes and signatures:
 ambart C.P. 46
 H.C.
 (initials)
 (initials)
 (initials)